30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS - CNTU
ADV.(A/S)	: JONAS DA COSTA MATOS
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL DRª MAÍRA FACHINI - AMN-MF
ADV.(A/S)	: DOUGLAS BORGES DE VASCONCELOS

EMENTA: PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI 12.871/2013. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS – CNTU. IRREGULARIDADE DO REGISTRO SINDICAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.

1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU teve invalidado, por decisão judicial, seu registro sindical, de modo a carecer de legitimidade ativa *ad causam*. Precedente: ADI 4.380 (Ministro CELSO DE MELLO).

2. O amplo rol de legitimados universais do art. 103 da Constituição não se coaduna com o afastamento do necessário vínculo entre o objeto impugnado e as finalidades próprias e específicas da confederação sindical. Ausência de pertinência temática.

3. Ilegitimidade ativa *ad causam* reconhecida.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14486974.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos, acordam em acolher a preliminar de ilegitimidade ativa *ad causam* da requerente e determinar a extinção do processo, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski. Falou, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União.

Brasília, 30 de novembro de 2017.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator para acórdão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14486974.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS - CNTU
ADV.(A/S)	: JONAS DA COSTA MATOS
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL DRª MAÍRA FACHINI - AMN-MF
ADV.(A/S)	: DOUGLAS BORGES DE VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O assessor Dr. Marcelo Novelino Camargo prestou as seguintes informações:

> A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU busca a declaração de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos artigos 3º a 14 da Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, que instituiu o denominado Programa Mais Médicos.
>
> Eis o teor dos dispositivos impugnados:
>
> [...]
>
> Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:
>
> I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de medicina, ouvido o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

Ministério da Saúde;

II - procedimentos para celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliativos necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do *caput*, deverá ser considerada, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do *caput*, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer, para a instituição de educação superior vencedora do chamamento público, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do *caput* observará,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos, exigirá garantia de proposta do participante, e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto respectivamente no art. 56 e no inciso II do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Medida Provisória.

Art. 4º Para os ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1º de janeiro de 2015, a formação do médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares entre si, correspondendo:

I - o primeiro ciclo, à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da carga horária não inferior a sete mil e duzentas horas; e

II - o segundo ciclo, a treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Educação - CNE, homologada pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 1º O segundo ciclo não dispensa o estudante de medicina do estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço supervisionado, em regime de internato, desenvolvido durante o primeiro ciclo do curso e disciplinado em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º Sem prejuízo da necessária supervisão acadêmica a cargo da instituição de educação superior à qual o estudante de medicina esteja vinculado, o segundo ciclo será realizado sob supervisão técnica de médicos, detentores de título de pós-graduação.

§ 3º Durante a realização do segundo ciclo, é assegurada aos estudantes de medicina a percepção de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, em valor estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde.

Art. 5º Ao estudante de medicina aprovado no primeiro ciclo, conforme certificado expedido pela correspondente instituição de educação superior, será concedida permissão para o exercício profissional da medicina, válida exclusivamente para as atividades do segundo ciclo de formação.

§ 1º A inscrição no segundo ciclo de formação é condição necessária e suficiente para expedição da permissão de exercício profissional de que trata o *caput* pelos Conselhos Regionais de Medicina.

§ 2º O segundo ciclo de formação é considerado componente curricular obrigatório do curso de graduação em medicina e será inscrito no histórico escolar do estudante.

§ 3º O diploma de médico somente será conferido ao estudante de medicina aprovado no segundo ciclo de formação.

§ 4º O segundo ciclo de formação poderá ser aproveitado como uma etapa dos programas de residência médica ou de outro curso de pós-graduação, nos termos definidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde, ouvida a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.

Art. 6º As instituições de ensino superior promoverão a adequação da matriz curricular dos cursos de medicina para atendimento ao disposto nesta Medida Provisória, nos prazos e na forma definida pelo CNE, em parecer homologado pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, para submeter o parecer referido no *caput* ao Ministro de Estado da Educação.

Art. 7º Fica instituído, no âmbito do Programa Mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observará a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante - médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista - médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamentos e os recessos.

Art. 8º O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o *caput* terá prazo de até três anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à aprovação nas avaliações periódicas.

Art. 9º Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimentos de língua portuguesa.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 10. O médico intercambista exercerá a medicina

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Fica vedado ao médico intercambista o exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

§ 2º Para exercício da medicina pelo médico intercambista no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil será expedido registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina.

§ 3º A declaração de participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, fornecida pela coordenação do programa, é condição necessária e suficiente para a expedição de registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina, não sendo aplicável o art. 99 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 4º O registro provisório será expedido pelo Conselho Regional de Medicina no prazo de quinze dias, contado da apresentação do requerimento pela coordenação do programa de aperfeiçoamento, e terá validade restrita à permanência do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do regulamento.

§ 5º O médico intercambista registrado provisoriamente estará sujeito à fiscalização e ao pagamento das anuidades estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito, conforme legislação aplicável aos médicos inscritos em definitivo.

§ 6º O médico intercambista não participará das eleições do Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito.

Art. 11. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

empregatício de qualquer natureza.

Art. 12. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de três anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 8º, mediante declaração da coordenação do projeto.

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o *caput* aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei nº 6.815, de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 13. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no *caput*, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de três bolsas-formação.

§ 2º Fica a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

> § 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.
>
> Art. 14. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na condição de contribuinte individual, na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
>
> Parágrafo único. Ficam ressalvados da obrigatoriedade de que trata o *caput* os médicos intercambistas:
>
> I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou
>
> II - filiados a regime de seguridade social no seu país de origem, que mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.
>
> [...]

A requerente assevera ter legitimidade para a propositura da ação por ser confederação sindical regularmente inscrita no Ministério do Trabalho. Sob a óptica da pertinência temática, aduz haver nexo entre as próprias finalidades institucionais e o conteúdo das normas impugnadas, as quais afetam diretamente o interesse da categoria de médicos.

No mérito, alega a impropriedade da veiculação da matéria por medida provisória, seja por inexistir urgência a justificar a edição, seja por tratar de cidadania, tema expressamente vedado pelo texto constitucional. Articula com a mitigação do princípio do concurso público, ante a ausência de processo seletivo para a admissão de profissionais no âmbito do programa. Aponta a precarização nas relações de trabalho pelo afastamento de vínculo empregatício de qualquer natureza, bem como pela forma de contratação e pagamento dos médicos cubanos. Diz da violação aos valores sociais do trabalho em razão da imposição de segundo ciclo de treinamento em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

serviço, com duração mínima de dois anos, para a formação de médicos, por caracterizar espécie de "serviço civil obrigatório". Argui a incompatibilidade da autorização para o exercício da medicina antes do cumprimento dos dois ciclos de formação e da dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas com o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 208 da Constituição Federal. Alude à imprescindibilidade de proficiência na língua portuguesa para a adequada prestação de atendimento médico, sendo insuficiente a exigência de mero conhecimento do idioma. Assinala o desrespeito à regra da reciprocidade, considerada a diferença de tratamento conferido aos brasileiros residentes no exterior. Enfatiza a ausência de isonomia em decorrência de os pacientes serem atendidos, em determinadas regiões, por médicos devidamente capacitados e, em outras, por profissionais ainda em formação ou com diploma não revalidado. Frisa violar o princípio da autonomia universitária, porquanto afeta diretamente o funcionamento de tais instituições, a criação de regras modificativas do plano de formação a ser observado nos cursos de medicina.

Sob o ângulo do risco, menciona a possibilidade de exercício profissional por médicos estrangeiros inscritos como intercambistas sem a necessária revalidação do diploma. Buscara o deferimento de liminar para suspender os efeitos da medida provisória até a apreciação pelo Congresso Nacional. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Ante a parcial coincidência de objetos, Vossa Excelência determinou o apensamento a este processo, com impugnação mais ampla, do revelador da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, para julgamento conjunto.

Nesta última, as requerentes pedem a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, 7º, incisos I e II e parágrafos 1º e 2º, incisos I e II, 9º, incisos I e II e § 1º, 10, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e 11 da Medida Provisória nº 621/2013.

Em preliminar, a Associação Médica Brasileira – AMBR realça a própria legitimidade ativa, por ser entidade de classe

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

de âmbito nacional voltada à defesa da dignidade profissional dos médicos e à assistência de qualidade à saúde da população. Daí a pertinência temática. O Conselho Federal de Medicina – CFM pleiteia ser admitido como parte legítima ou como terceiro interessado, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. No mérito, ambos alegam a impropriedade de veiculação do tema por medida provisória, seja por não ter sido verificada a urgência constitucionalmente exigida, seja pela impossibilidade de tal ato normativo regulamentar matérias atinentes a orçamento ou reservadas a lei complementar. Sob a óptica material, apontam contrariar os princípios da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade humana, da segurança e da proteção à saúde a autorização, para o exercício da medicina, a profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior, sem a devida revalidação do diploma. Dizem transgredir o princípio da isonomia o tratamento diferenciado conferido a esses médicos, assim como aos pacientes por eles atendidos. Sustentam que o programa autoriza o exercício ilegal da medicina ao permitir a atuação de profissionais da área sem o prévio registro nos Conselhos Regionais. Argumentam, considerada a inobservância de normas protetivas das relações laborais, estar configurada "verdadeira escravidão disfarçada de intercâmbio", a violar tratados internacionais de direitos humanos e direitos sociais do trabalho. Sublinham o desrespeito ao princípio da autonomia universitária. Aduzem ser incompatível com o princípio da legalidade a inexistência de critérios objetivos para a análise do conhecimento da língua portuguesa, de modo a viabilizar a prática da medicina por estrangeiros sem a adequada proficiência. Ressaltam a ingerência estatal indevida na autonomia dos Conselhos de Medicina, compelidos a expedir registros provisórios aos profissionais participantes do programa. Arguem afronta às exigências de concurso público e de processo licitatório pelas normas autorizativas da contratação de médicos para o programa, ante a não imposição de realização de processo seletivo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

Sob o ângulo do risco, destacam os perigos à segurança e à saúde da população decorrentes do exercício da medicina por indivíduos sem as necessárias qualificações técnicas. Postularam o implemento de liminar para suspender as normas impugnadas. No mérito, pretendem a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos atacados.

Vossa Excelência, em 31 de agosto de 2013, nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou informações.

A Câmara dos Deputados limita-se a enfatizar a estrita observância, no âmbito do Congresso Nacional, dos preceitos constitucionais e regimentais relativos ao processo legislativo.

A Presidente da República, após breve descrição do Programa Mais Médicos, suscita, em preliminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF, a ilegitimidade ativa da requerente, uma vez não comprovada a pertinência temática. No mérito, em ambas as ações, afirma presentes a relevância e a urgência a justificarem ser a matéria versada em medida provisória, alegando não haver erro grosseiro ou atributo inadequado a configurar "evidente abuso de discricionariedade" sujeito ao controle judicial. Sob a óptica material, sustenta a impossibilidade de enquadrar-se a concessão de visto temporário aos médicos intercambistas estrangeiros como matéria referente à cidadania, conceito relacionado aos brasileiros natos e naturalizados. Esclarece tratar-se de programa de capacitação, inexistente relação de emprego a respaldar a incidência de normas trabalhistas. Diz da inadequação de interpretar-se o treinamento em serviço, mudança de paradigma pedagógico voltada a priorizar a atuação preventiva na atenção básica, como imposição de trabalho obrigatório aos estudantes de medicina. Defende ser descabido falar em exercício ilegal do ofício, considerada a dispensa de revalidação dos diplomas, por existirem mecanismos de avaliação utilizados para aferir a qualificação profissional e, inclusive, o conhecimento da língua portuguesa. Ressalta a ausência de obrigatoriedade de revalidação do diploma para todos que não se sujeitam a condições de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

reciprocidade. Argumenta não ter sido apontado qualquer dispositivo a criar diferenciação entre pacientes das distintas regiões do País, sendo as preferências por certos locais decorrentes de opção dos próprios médicos. No tocante à autonomia universitária, aduz a hierarquia legal dos preceitos supostamente violados, passíveis de revogação por medida provisória. Alfim, anexa pareceres das consultorias jurídicas junto aos Ministérios da Educação e da Saúde, nos quais analisada a constitucionalidade do Projeto Mais Médicos para o Brasil, bem como o relatório de estatísticas sanitárias mundiais, elaborado pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

O Senado Federal, em preliminar, sustenta a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, por falta de pertinência temática. No mérito, alega caber apenas aos Poderes Executivo e Legislativo a análise da presença dos pressupostos para edição de medidas provisórias, salvo em situação de abuso, não demonstrada no caso. Assinala a ausência dos requisitos autorizadores para o implemento da medida liminar.

O Advogado-Geral da União, após tecer considerações acerca do Programa Mais Médicos, destaca haver relevância e urgência para a edição da medida provisória, sublinhando ser a aferição de tais condições pelo Poder Judiciário providência de caráter excepcional. Menciona a imprescindibilidade de recrutamento de médicos estrangeiros devido à insuficiência de profissionais no mercado de trabalho brasileiro e à má distribuição territorial. Realça ser desnecessária a imposição de revalidação do diploma obtido no exterior, ante a exigência de conhecimento de língua portuguesa, a avaliação por instituições de ensino e a restrição do exercício das atividades ao âmbito do projeto, sob contínuo monitoramento de instituição acadêmica supervisora. Quanto à inclusão do segundo ciclo de formação profissional, elucida consistir em treinamento com enfoque na atenção básica à saúde, podendo ser aproveitado como etapa da residência ou pós-graduação. Frisa contribuir para o aprimoramento da formação médica no Brasil. Na manifestação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

formalizada na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, além dos citados argumentos, aponta irregularidade na representação da Associação Médica Brasileira, por não constar a especificação dos dispositivos impugnados, requisito indispensável para o reconhecimento da capacidade postulatória da requerente. Argui a ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina, em virtude de ser conselho corporativista não previsto no rol de legitimados do artigo 103 da Lei Maior.

Em 6 de novembro de 2013, Vossa Excelência acionou o § 1º do artigo 9º da Lei nº 9.868/1999, visando obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre a matéria, sobretudo por revelar processo objetivo, no qual ausentes interesses individualizados. Assegurou-se a participação de entidades, autoridades e profissionais, cujos pedidos foram recebidos por correio eletrônico. As sessões ocorreram em 25 e 26 de novembro de 2013.

Na abertura, o então advogado-geral da União, Luís Inácio Lucena Adams, discorreu sobre o Sistema Único de Saúde – SUS e o Programa Mais Médicos, reafirmando os termos anteriormente expostos.

Após, Roberto Luiz D`Ávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, manifestando-se de forma contrária ao programa, destacou a ofensa ao princípio da isonomia, em razão da dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas e da diferenciação quanto ao tratamento dado aos pacientes mais carentes, usuários do serviço de saúde pública, e daquele conferido aos dotados de recursos para arcar com despesas médico-hospitalares.

A seguir, Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde, ressaltou a importância do programa, voltado à atenção básica, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Elucidou o liame entre a reformulação dos cursos de medicina e a abertura à participação de médicos estrangeiros. Apontou, como justificativa para a dispensa de revalidação do diploma, a necessidade de restringir a atuação dos médicos intercambistas,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

impedindo-os de atuar em outras áreas.

Na sequência, Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente da Associação Médico-Oncologista, salientou os problemas resultantes da falta de investimento e de gestão qualificada na saúde. Questionou aspectos estruturais do Programa Mais Médicos, suscitando incoerências e contradições nas medidas implementadas.

Na continuação dos trabalhos, José Luiz Bonamigo Filho, diretor da Associação Médica Brasileira, realçou a importância da aplicação do Revalida, avaliação instituída pelo governo para validar diplomas obtidos no exterior. Disse do elevado índice de reprovação no exame e alertou para os riscos do desconhecimento do nível de qualificação dos profissionais estrangeiros.

Em seguida, Paulo Speller, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, frisou os objetivos do programa, sobretudo no tocante à integração ensino-serviço. Apontou a baixa média brasileira de médicos por habitantes e a desigualdade na distribuição desses profissionais nas regiões do País, acentuando a premência de expansão do número de vagas nos cursos de medicina. Reportou-se à instituição de medidas voltadas a reduzir, de forma gradativa, a necessidade de médicos intercambistas.

Dando continuidade à audiência, Sebastião Vieira Caixeta, procurador do Ministério Público do Trabalho, informou a instauração de inquérito civil para apurar denúncia acerca de problemas e irregularidades envolvendo o programa. Discorreu sobre o possível desvirtuamento da relação de trabalho travestida de curso de especialização; a contratação de médicos sem qualquer tipo de procedimento seletivo; a dispensa da revalidação do diploma para participantes do programa; e, em especial, o tratamento diferenciado conferido aos médicos cubanos.

Reiniciando-se os trabalhos na parte da tarde, Vagner Freitas de Moraes, presidente da Central Única dos Trabalhadores, destacou o apoio da direção executiva da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

entidade ao programa. Embora tenha reconhecido a necessidade de aprimoramento das condições de trabalho para o adequado exercício da profissão, apontou a falta de médicos para o atendimento da população menos abastada como um dos principais problemas na área da saúde.

Foi ouvido, a seguir, Ruy Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho. Referiu-se ao acordo judicial firmado em ação civil pública no qual a União se obriga a não mais terceirizar atividades-fim. Disse da inobservância do dever de tratamento isonômico entre trabalhadores vinculados direta ou indiretamente à Administração Pública.

Na sequência, José Alberto Reus Fortunati, prefeito de Porto Alegre/RS e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, relatou a dificuldade na contratação de recursos humanos pelos Municípios, em especial de médicos. Salientou a importância do Sistema Único de Saúde e do Programa Mais Médicos para o atendimento à população carente, ressaltando a primordialidade de aperfeiçoamento do atual sistema.

Na continuação dos trabalhos, Fernando Casquel Monti, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realçou o problema da falta de médicos no âmbito municipal. Enfatizou a dificuldade no preenchimento das vagas por concurso público. Reiterou os pontos positivos do programa.

A promotora de justiça do Ministério Público do Tocantins e primeira vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde – AMPASA, Maria Rosely de Almeida Pery, após reconhecer que deveria haver melhorias estruturais das carreiras na área da saúde, apontou a indispensabilidade de resposta urgente, como a efetivada pelo programa, para o atendimento das necessidades básicas da população menos favorecida.

Após breve intervalo, ouviu-se o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Mozart Túlio Tabosa Sales frisou a diferença entre o amplo exercício da profissão, garantido pela revalidação dos diplomas,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

e o programa destinado à atenção básica, em que os médicos são constantemente avaliados pelas universidades públicas federais. Destacou ser necessário restringir a atuação dos profissionais intercambistas.

Na sequência, Marcelo André Barboza da Rocha Chaves, titular da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, abordou os objetivos do programa, assim como o objeto de análise e a atuação do Órgão de contas federal em relação ao tema. Em especial, realçou os problemas envolvendo o pagamento dos médicos cubanos.

O deputado federal Henrique Mandetta assinalou a impossibilidade de acesso ao conteúdo do convênio celebrado pelo governo brasileiro com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS e com Cuba, cujos termos não foram objeto de análise pelo Congresso Nacional, por terem sido divulgados apenas após o período de deliberação das emendas parlamentares.

Na continuação dos trabalhos, o também deputado federal Ronaldo Caiado ressaltou as obscuridades e a falta de debates parlamentares acerca do teor do referido convênio, a despeito dos requerimentos feitos ao Ministério das Relações Exteriores. Asseverou a falta de equidade no tratamento conferido aos médicos intercambistas cubanos e aos europeus.

Por último, o médico William José Bicalho Hastenreiter Paulo, participante do Programa Mais Médicos, relatou que, embora tratado como estudante bolsista, nunca recebeu o devido acompanhamento de tutor. Afirma submeter-se a rotina normal de trabalho, mas sem a garantia de direitos trabalhistas.

O segundo dia de audiências públicas foi aberto por Geraldo Ferreira Filho. O presidente da Federação Nacional dos Médicos e dos Sindicatos dos Médicos do Rio Grande do Norte sublinhou a precarização das relações trabalhistas no âmbito do programa, em desarmonia com a Constituição, a Consolidação das Leis do Trabalho e os tratados internacionais sobre o tema. Disse ter natureza trabalhista o vínculo entre os médicos participantes do programa e o Estado brasileiro, embora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

disfarçado de ensino.

Em seguida, a presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, Jadete Barbosa Lampert, fez ponderação entre os avanços quantitativos e os riscos qualitativos da assistência médica ofertada pelo programa. Salientou a relevância do estímulo à capacitação profissional para o fomento da qualidade dos serviços assistenciais e de saúde.

No final da manhã, Lúcia Nader, diretora da Conectas Direitos Humanos, após breve análise do contexto global envolvendo os direitos humanos, referiu-se ao direito à saúde, à migração e aos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Articulou com a impossibilidade de questões burocráticas, como o acesso a cargos públicos e a exigência de revalidação de diplomas, servirem de óbice ao direito migratório. Alertou para a insuficiência do programa diante dos obstáculos existentes. Defendeu a necessidade de soluções estruturais e duradouras.

Na reabertura dos trabalhos, Vasco Vasconcelos, representante da Associação Ordem dos Bacharéis do Brasil, arguiu a imprescindibilidade da contratação de médicos brasileiros e estrangeiros, devido à falta de profissionais nas regiões mais carentes do País. Alegou inexistir violação a normas constitucionais, morais ou éticas pela legislação instituidora do programa.

O ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Marcelo Côrtes Néri, apresentou pesquisas indicando a saúde como prioridade para a população brasileira e a carência de médicos como o principal problema, sobretudo nas localidades menos abastadas do Brasil. Discorreu sobre o baixo crescimento do número de vagas em medicina na comparação com outros cursos. Acentuou a importância da manutenção do programa para fomentar a acessibilidade da assistência à população menos favorecida. O coordenador da área de saúde do referido instituto, Matheus Stivali, abordou os impactos sistêmicos do programa e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

estrutura da Federação brasileira, segundo a qual cabe aos Municípios a atenção básica à saúde. Destacou a heterogeneidade municipal entre as causas das destoantes realidades. Mencionou a competência atribuída à União no âmbito do Programa Mais Médicos. Expôs a urgência da atuação em frentes de curto e longo prazo, referentes, respectivamente, à recepção dos médicos intercambistas e à modificação do currículo dos cursos de medicina.

Finalizando a audiência pública, Juracy Barbosa Júnior, representante da Associação Nacional dos Médicos Residentes, reportou-se à necessidade de adequada avaliação dos profissionais estrangeiros. Apontou a qualidade dos serviços prestados, e não a quantidade de médicos, como o principal problema da saúde no Brasil.

O Procurador-Geral da República, em preliminar, suscita a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, por ausente a pertinência temática. Argumenta que o fato de congregar todos os profissionais liberais com nível superior reconhecido confere à requerente legitimidade ativa quase universal. Assinala a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, por falta de aditamento da inicial, considerada a conversão da medida provisória impugnada em lei. Alude à irregularidade na representação processual da Associação Médica Brasileira – AMBR, ante a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação. Aponta a ilegitimidade do Conselho Federal de Medicina – CFM, por se tratar de autarquia corporativista. Em ambas as ações, após traçar breve histórico do Programa Mais Médicos, delimita o objeto da ação à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Medida Provisória nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013. Diz excluídas do âmbito do julgamento questões individuais e as atinentes à execução financeira do projeto, entre elas o convênio celebrado com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS. No mérito, articula com a impropriedade da alegação de falta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

de urgência para tratar de alteração curricular prevista no artigo 4º da Medida Provisória nº 621/2013, ante a mudança promovida pela lei de conversão. Sustenta incabível o exame judicial dos requisitos de relevância e urgência, uma vez não verificado manifesto abuso do Poder Executivo. Ressalta não ter o ato normativo impugnado tratado de cidadania nem de qualquer outra matéria vedada pelo § 1º do artigo 62 da Constituição da República. Pondera acerca da inviabilidade de reconhecimento de vínculo empregatício aos médicos intercambistas, considerada a proibição constitucional de contratação direta pelo regime celetista. Salienta tratar-se de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Carta Federal, regulamentado pela Lei nº 8.745/1993. Assevera a perda do objeto no tocante à instituição do segundo ciclo no curso de graduação em medicina e ao exercício da profissão por estudante nele matriculado, tendo em vista a retirada do preceito atacado da lei de conversão. Realça a possibilidade de a liberdade profissional ser condicionada às qualificações estabelecidas por lei. Quanto à revalidação do diploma, frisa tratar-se de matéria legal, passível de ser excepcionada por norma de mesma hierarquia. Aduz dispensável a revalidação para os médicos participantes do programa em virtude de estarem submetidos a regime jurídico específico, por prazo determinado e sob a fiscalização do respectivo Conselho Regional de Medicina. Observa inexistir ofensa ao artigo 13 do Diploma Maior, considerada a exigência de domínio da língua portuguesa pelos médicos participantes do programa, cujo primeiro módulo é voltado ao aperfeiçoamento do estudo do idioma. Esclarece que o artigo 112, inciso IV, do Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 6.815/1980 – em momento algum exige proficiência do naturalizado, mas apenas saber "ler e escrever a língua portuguesa". Sublinha ser a reciprocidade, prevista no artigo 12, § 1º, da Constituição Federal, aplicável apenas aos portugueses, inexigível em relação aos direitos assegurados no âmbito do programa no qual

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

implementada política pública voltada ao atendimento das necessidades da população brasileira. Diz ser desprovido de fundamentação lógica o argumento de violação à isonomia entre os pacientes das diferentes regiões do País, considerado o reconhecimento constitucional da existência de desigualdades regionais, inclusive no âmbito da saúde, a justificar tratamentos diferenciados. Enfatiza que a autonomia universitária não impede a União de criar ato normativo instituindo diretrizes curriculares específicas para o curso de medicina, delegando competências gerenciais ao Ministro da Educação ou determinando a adequação das instituições de ensino superior. Na conclusão, opina pelo não conhecimento da ação ou, caso conhecida, pela total improcedência do pedido. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, manifesta-se pela intimação da Associação Médica Brasileira – AMB para regularizar a petição inicial e a respectiva documentação anexada e, no mérito, pela improcedência total do pleito.

Vossa Excelência deferiu a intervenção da Associação Médica Nacional Dra. Maíra Fachini – AMN-MF como terceira interessada. O mesmo ocorreu em relação ao Conselho Federal de Medicina – CFM, excluído do polo ativo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, por ausência de legitimidade. Foram indeferidos os pedidos de ingresso da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social e da Federação Nacional dos Médicos.

Devido à conversão da medida provisória, houve aditamento para requerer-se o prosseguimento das ações no tocante à Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Os termos de ambas as iniciais foram integralmente ratificados, alegando-se a inexistência de alteração substancial das normas atacadas.

Os dispositivos correspondentes aos expressamente impugnados passaram a ter a seguinte redação:

> Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de Medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Lei.

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que:

I - possuam certificação como hospitais de ensino;

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus serviços.

§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde.

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I - os seguintes critérios de qualidade:

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas;

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:

a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na região;

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza.

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo constitui ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

[...]

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da matriz curricular para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao Ministro de Estado da Educação.

[...]

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à sua aprovação nas avaliações periódicas.

§ 3º O primeiro módulo, designado acolhimento, terá

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

duração de 4 (quatro) semanas, será executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da Atenção Básica em saúde, aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde, à língua portuguesa e ao código de ética médica.

§ 4º As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e compreenderão o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o médico participante está apto ou não a continuar no Projeto.

§ 5º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas avaliações de que tratam os §§ 1º a 4º, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a programação em módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 3º A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, para todos os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão médica e à tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Vide Decreto nº 8.126, de 2013)

§ 1º (VETADO).

§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.

§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

respectivos números de registro único.

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto.

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o *caput* aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

> § 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.
>
> § 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.
>
> Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
>
> Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os médicos intercambistas:
>
> I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou
>
> II - filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.
>
> [...]

A Associação Médica Brasileira juntou, ainda, nova procuração com poderes específicos para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF.

O Conselho Federal de Medicina, a fim de comprovar as irregularidades suscitadas, promoveu a juntada de relatório do Tribunal de Contas da União referente ao Programa Mais Médicos e de Projeto de Decreto Legislativo voltado à sustação do "Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto 'ampliação do acesso da população brasileira à atenção básica em saúde', celebrado entre o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde". Mencionou o endereço

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

eletrônico para acesso a reportagens sobre o tema transmitidas pela Rede Bandeirantes de Televisão.

Em 25 de fevereiro de 2016, Vossa Excelência indeferiu o pleito de extinção da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF formulado pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, ante a falta de admissibilidade do ingresso da postulante como terceira.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185533.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – As ações diretas versam sobre normas instituidoras do Programa Mais Médicos, criado com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde – SUS. Entre as medidas a serem adotadas para a consecução dos objetivos visados pelo programa estão a reordenação da oferta dos cursos de medicina e de vagas para a residência médica, o estabelecimento de novos parâmetros para a formação de médicos e o incentivo ao aperfeiçoamento desses profissionais na área de atenção básica em saúde – artigos 1º e 2º da Lei nº 12.871/2013.

Cumpre, inicialmente, delimitar o objeto desta análise, ante o pedido abrangente formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF, no sentido de ser "reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos da Medida Provisória n° 621/2013, que trata de Programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, com a Ordem Constitucional vigente, em especial de seus artigos 3° a 8°, 9°, 10°, 11°, 13° e 14° [...]".

No controle concentrado, embora a causa de pedir seja aberta, a atuação do Tribunal deve ficar adstrita aos limites do pedido. Excetuadas as hipóteses de interdependência com os dispositivos atacados ou de inconstitucionalidade consequente, descabe proclamar, de ofício, a nulidade de normas não impugnadas de maneira específica pelo requerente. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.895/AL, relator ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno; e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.645/PR, relatora ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno.

No tocante à relação entre as ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.035 e nº 5.037, verifico a identidade quase total entre os pleitos veiculados nas respectivas petições iniciais. A distinção reside na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

amplitude do objeto dos processos. A autora da ação direta nº 5.037 busca a declaração de inconstitucionalidade de mais preceitos da norma atacada, em comparação ao postulado na ação direta nº 5.035. Sob esse ângulo, o exame do versado na ação nº 5.037 necessariamente resultará na apreciação dos requerimentos da de nº 5.035, razão pela qual procedo ao julgamento conjunto dos processos.

I) DAS PRELIMINARES

I.1) DA REGULARIDADE DO MANDATO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

Quanto ao argumento do Ministério Público de irregularidade da representação processual da Associação Médica Brasileira, observo que a autora juntou, após a formalização desta ação direta, procuração especificamente direcionada à atuação neste processo. Embora não explicitados, no instrumento, os dispositivos impugnados, a superveniente regularização da representação processual acaba por superar o vício. É que não não cabe exarcerbar a forma. Quando o legislador entendeu necessário o fez, como é exemplo a disciplina da matéria na queixa-crime ligada à honra. Afasto a preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República.

I.2) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

O Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República arguiram a ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina, considerada a natureza de conselho corporativista, não inserido no rol de legitimados a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Em 5 de abril de 2016, determinei a exclusão da autarquia do polo ativo da ação direta nº 5.037, por não se enquadrar nos requisitos do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal. Assentei adequada a admissão na condição de terceiro, no que ficou esvaziada a preliminar articulada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

I.3) DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS – CNTU

Alega-se ausente a pertinência temática, em razão de ser entidade composta por associados com interesses distintos.

O Supremo tem, historicamente, imposto limites subjetivos ao exercício da legitimidade prevista no inciso IX do artigo 103 da Carta de 1988. Desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 42/DF, relator ministro Paulo Brossard, em 24 de setembro de 1992, adota definição restritiva de entidades de classe: são aquelas a representarem grupo de pessoas que exercem as mesmas atividades profissionais ou econômicas. O traço distintivo seria, como destacou o ministro Sepúlveda Pertence em voto proferido no aludido processo, a identidade ou semelhança da atividade empresarial ou profissional ou do setor econômico. Assentou estar o sentido da expressão "classe" preso à ideia de profissão ou de segmento econômico, considerado interesse objetivo homogêneo entre os associados. O caráter econômico ou profissional das entidades e a homogeneidade de interesses dos associados seriam, em última análise, os requisitos imprescindíveis da legitimidade versada no inciso IX do artigo 103.

Com essas premissas, o Tribunal afastou a legitimidade da União Nacional dos Estudantes – UNE (ação direta de inconstitucionalidade nº 894/DF, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, apreciada em 18 de novembro de 1993), da Associação Brasileira de Defesa do Cidadão – ABRADEC, associação civil de finalidade altruísta (ação direta de inconstitucionalidade nº 61/ES, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgada em 29 de agosto de 1990), de associação de profissionais de categorias heterogêneas (ação direta de inconstitucionalidade nº 34/DF, relator ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, examinada em 5 de abril de 1989), de associação de associações (ação direta de inconstitucionalidade nº 1.037/SC, relator ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Moreira Alves, Tribunal Pleno, analisada em 3 de junho de 1998), de associação de órgãos públicos (ação direta de inconstitucionalidade nº 67/DF, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, apreciada em 18 de abril de 1990).

Também foi rígido na caracterização da qualificadora de âmbito nacional, exigindo das entidades de classe a existência de membros em pelo menos nove Estados da Federação – ação direta de inconstitucionalidade nº 386/DF, relator ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgada em 4 de abril de 1991, Diário da Justiça de 28 de junho seguinte.

Somada ao requisito da pertinência temática, a ser observado quando envolvidos os denominados legitimados especiais, a definição bastante estreita da categoria entidades de classe acabou revelando que estas apenas podem defender interesses exclusivos dos associados, profissionais e econômicos. Não lhes seria permitido, por falta de pertinência temática, buscar a garantia de direitos e interesses coletivos, direitos fundamentais e da cidadania que aproveitem a toda a sociedade ou a grupos particulares, salvo se como mero reflexo da promoção dos direitos corporativos dos associados.

Estou convencido, a mais não poder, de ser a hora de o Tribunal evoluir na interpretação do artigo 103, inciso IX, da Carta da República, de modo a ampliar a legitimação conferida às entidades de classe e confederações sindicais.

Não há qualquer razão legítima a justificar a visão restritiva do Supremo. Não é alcançada ante a interpretação literal, pois a palavra "classe" é vaga, comportando leituras muito mais generosas. A percepção não se concilia com a interpretação teleológica da Lei Básica da República, pois frustra o propósito do Texto Maior, que é democratizar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade. Pior, colide frontalmente com a interpretação sistemática da Carta, afrontando o postulado de unidade da Constituição Federal.

De muito, concordo com a óptica segundo a qual o constituinte originário visou a amplitude maior do rol de legitimados. Foi o que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

consignei, em voto vencido, no exame da mencionada ação direta de inconstitucionalidade nº 1.037/SC, ocasião em que defendi a legitimidade da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL:

> Senhor Presidente, sou daqueles que acreditam no rol do artigo 103 da Carta da República; que houve, quando dos trabalhos da Assembleia Constituinte, uma opção visando-se justamente a elastecer os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo foi abrir a possibilidade, abandonando-se o nefasto monopólio do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República, de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

No caso, encontra-se preenchido o requisito da pertinência temática, considerado o estreito vínculo entre os objetivos institucionais da entidade e a matéria analisada, a afetar diretamente interesses da classe médica, uma das categorias representadas pela requerente.

Entendo que restringir o conceito de entidade de classe e de confederação sindical implica, ao reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil, amesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta da República. Reconheço a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU.

I.4) DA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA NOS CASOS DE VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de exigir-se, para o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, ofensa frontal ao texto da Lei Maior – ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.243, da minha relatoria, Tribunal Pleno; nº 2.714, relator ministro Maurício Corrêa; nº 2.628, redatora do acórdão ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno; nº 1.900, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno; nº 147, relator ministro Carlos Madeira, Tribunal Pleno.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

No tocante aos argumentos envolvendo a falta de domínio do idioma, a indevida interferência na autonomia dos conselhos regionais e a necessidade de tratamento recíproco para validação de diploma obtido no exterior – respectivamente, artigos 15, § 1º, III, e 16, cabeça e parágrafos 2º a 4º, da Lei nº 12.871/2013 –, embora mencionadas normas constitucionais supostamente infringidas, todo o raciocínio veiculado pelas requerentes é desenvolvido a partir do cotejo com dispositivos infraconstitucionais.

Na ação direta nº 5.035/DF, sustenta-se que a simples exigência de "possuir conhecimento em língua portuguesa" afronta o princípio da legalidade, consagrado nos artigos 5º, inciso II, e 37 da Lei Fundamental. Na ação direta nº 5.037/DF, aduz-se violação ao artigo 13 do Diploma Maior, segundo o qual a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, bem como a prescrição de proficiência contida no artigo 112 da Lei nº 6.815/1980 e na Portaria nº 1.350/2010.

Quanto à alegada ingerência estatal na autonomia dos Conselhos de Medicina, a Associação Médica Brasileira argui a impossibilidade de afastamento, por meio de medida provisória, do artigo 99 da Lei nº 6.815/1980, bem como do artigo 17 da Lei nº 3.268/1957, por serem "legislações específicas para a habilitação médica em complemento ao artigo 5°, XIII, da Constituição", no qual assegurada a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Relativamente à necessária reciprocidade no tratamento conferido aos brasileiros pelos demais países, formulada na ação direta nº 5.037, a autora alega desrespeito ao artigo 12 da Carta Federal. Consoante afirma, o ato atacado ignora o disposto no artigo 48 da Lei nº 9.394/1996, que condiciona a validação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras à existência de acordo internacional de reciprocidade.

Em todas essas situações, não há transgressão direta ao texto constitucional a ensejar a admissibilidade da ação no que concerne aos enunciados atacados. As supostas antinomias jurídicas, se existentes, devem ser resolvidas com base nos critérios hierárquico, cronológico ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

da especialidade, revelando-se inadequado, no caso, o controle normativo abstrato. Por ausente ofensa a dispositivo da Constituição Federal, as ações não devem ser admitidas no ponto.

II) DA PREJUDICIAL

II.1) DA PERDA PARCIAL DE OBJETO

Com a conversão da Medida Provisória nº 621/2013 em lei, foram alteradas as regras relativas ao funcionamento dos cursos de medicina, extinguindo-se a exigência de dois ciclos distintos e complementares entre si para a formação de médicos e, por conseguinte, a permissão para o exercício da profissão, exclusivamente observado o segundo ciclo de formação, após a aprovação no primeiro.

Consoante a jurisprudência do Supremo, fica prejudicada, em virtude da perda do objeto, a ação direta cujo ato normativo contestado sofre alteração substancial no conteúdo – ação direta de inconstitucionalidade nº 258/DF, relator ministro Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, e medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 991/DF, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno.

Verifico que as iniciais de ambas as ações foram aditadas pelas autoras, afastando o prejuízo arguido pelo Procurador-Geral da República em parecer juntado à ação direta nº 5.035. No tocante à de nº 5.037, não houve impugnação específica ao conteúdo do dispositivo na nova redação. Considerada a substancial mudança, assento o prejuízo do pedido no tocante à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 12.871/2013.

A análise das ações diretas deve ocorrer relativamente aos demais dispositivos da Lei nº 12.871/2013.

III) DO MÉRITO

III.1) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

As requerentes sustentam a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013, seja por ausente o pressuposto constitucional da urgência, seja por tratar de matérias expressamente vedadas pelo artigo 62, § 1º, inciso I, da Constituição da República.

A conversão em lei é incapaz de sanar eventuais nulidades inerentes à medida provisória, permanecendo hígida a possibilidade de controle.

Sob o ângulo formal, o Supremo admite caber ao Chefe do Executivo a avaliação de conveniência e oportunidade, ressalvados os casos de excesso de poder – ação direta de inconstitucionalidade nº 2.150-8/DF, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, publicada no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2002. O controle de constitucionalidade das medidas provisórias, quanto aos requisitos de relevância e urgência, ainda que excepcional, mostra-se viável quando manifesto o abuso.

Sempre consignei serem tais condições aferíveis por aquele que possui, no controle concentrado, a guarda da Constituição. Reconheço a existência de texto aberto no qual formuladas, a permitir múltiplas interpretações. Somente podem ser tidas como próprias ante a situação concreta. A indeterminação concernente aos conceitos versados na Constituição exige seja apreciada a opção do intérprete sob o ângulo conceitual, o que deve ser feito em observância ao princípio da separação de Poderes e à necessidade de reconhecer espaço legítimo de interpretação constitucional aos demais agentes políticos de cúpula do Estado. Em síntese, a inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 62 da Lei Maior deve resultar do contexto.

Em jogo faz-se a edição de medida provisória instituidora de políticas públicas na área da saúde voltadas, entre outras, à formação de profissionais, bem como ao fortalecimento da prestação de serviços essenciais. A relevância da matéria salta aos olhos, considerada a importância do tema, refletida nos graves problemas a afetar a atuação do Sistema Único de Saúde, sobretudo nas regiões mais carentes do País, sendo insuficiente, a mais não poder, a estrutura existente, notando-se falha no corpo funcional dedicado à saúde, conforme abordado a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Quanto à urgência para o implemento da medida, menciono a informação, veiculada na exposição de motivos da Medida Provisória nº 621/2013, de que o Brasil apresenta proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, média consideravelmente inferior à de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante e à de outros com sistemas universais de saúde. O mais grave: há grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões, verificando-se proporção inferior a 1 médico por 1.000 nos Estados do Acre (0,94), Amapá (0,76), Maranhão (0,58), Pará (0,77) e Piauí (0,92). Entre as explicações para o panorama, aponta-se o número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina, a refletir no número de médicos. Extraio desse quadro a justificativa de urgência no regramento.

Sob o ângulo material, descabe conferir aos conceitos de nacionalidade e cidadania sentido alargado, a abranger contratação e concessão de visto temporário para médicos intercambistas estrangeiros e dependentes legais. O texto impugnado não dispõe sobre o vínculo jurídico-político por meio do qual passam a conviver com os nacionais, nem versa acerca da participação nos negócios políticos do Estado ou em outras áreas de interesse público.

Também é impróprio agasalhar a tese de que a medida provisória disciplinou matéria orçamentária. O diploma normativo não trata de planejamento e execução de finanças públicas, tampouco contempla previsão de receitas e fixação de despesas. Veicula política pública referente à saúde, cumprindo ao Poder Executivo implementar, mediante instrumentos próprios, as providências necessárias ao custeio do programa.

Sob tais ângulos, não procedem as alegações de inconstitucionalidade formal e material suscitadas pelas requerentes, porquanto ausente tema constitucional vedado e configurada, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a situação de relevância e urgência a justificar a edição de normas provisórias pelo Presidente da República.

III.2) DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Faz-se em jogo analisar o regime jurídico aplicável aos médicos participantes do programa. As requerentes aduzem que os artigos 11, 13 e 14 da Medida Provisória nº 621/2013 – convertidos, respectivamente, nos artigos 17, 19 e 20 da Lei nº 12.871/2013 – padecem de inconstitucionalidade por mitigar o princípio do concurso público, afastar direitos sociais e tornar precárias as relações trabalhistas.

A Presidência da República afirma tratar-se de programa de capacitação executado na modalidade ensino-serviço, inexistente vínculo efetivo com os bolsistas e tampouco a criação de cargo, emprego ou função pública. A óptica não se coaduna com a realidade fática nem com os preceitos constitucionais atinentes à matéria.

As informações e esclarecimentos prestados durante a audiência pública revelam a inequívoca presença de relação de natureza trabalhista escamoteada de ensino-serviço[1]. Nas manifestações favoráveis ao programa, fica nítida a exclusiva finalidade de suprir a falta de médicos em determinadas regiões do País.

Não é razoável concluir pelo pagamento de bolsa para médicos estrangeiros se especializarem e, em seguida, sem qualquer indenização aos combalidos cofres públicos, retornarem aos países de origem.

No acórdão nº 1605-25/15-P, da relatoria do ministro Benjamin Zymler, o Tribunal de Contas da União chegou a recomendar ao Ministério da Saúde a reavaliação da necessidade e dos benefícios de oferecer cursos de especialização para médicos estrangeiros, considerado o seguinte cenário:

[…]

1 Segundo o procurador do trabalho Sebastião Vieira Caixeta, a análise das normas legais e documentos conjuntos assinados pelos gestores do programa, em inquérito civil promovido no âmbito do Ministério Público do Trabalho, revelou, "com muita clareza, que o que se tem, de fato, é uma relação de trabalho [...], embora mascarada por um programa de aperfeiçoamento que seria uma pós-graduação com foco no ensino, na pesquisa e na extensão[...]". O Doutor William José Bicalho Hastenreiter Paulo, médico participante do programa, disse trabalhar no atendimento à população como qualquer outro médico, sendo o único contato mantido com o tutor voltado apenas a informar quantos pacientes atende por dia.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> 25. Observou-se que, até 12/5/2014, 11.814 médicos intercambistas individuais estrangeiros ou cooperados (provenientes do acordo com a Opas) estavam em atividade. Considerando os gastos com tutores e supervisores e os custos do curso a distância ministrado para esses médicos, o dispêndio total da especialização somente para os médicos estrangeiros, nos três anos de projeto, ficará em R$ 242.782.748,72 (duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Isso quer dizer que o Governo Federal investirá cerca de R$ 240 milhões no prazo de três anos para especializar profissionais que, ao final do projeto, têm grandes chances de deixar o país e não aplicar aqui os conhecimentos adquiridos (TC nº 005.391/2014-8005.391/2014-8, peça 171, p. 40).

Quanto à ausência de certame para o ingresso de médicos no programa, de fato, no âmbito da administração pública, a regra é a admissão de pessoal mediante concurso. No caso, tem-se contratação por tempo determinado para satisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público, contemplada no artigo 39 inciso, IX, da Constituição. Trata-se de exceção à regra geral. A falta de concurso público justifica-se pelo número insuficiente de médicos para atender à demanda existente em certas regiões.

No julgamento do recurso extraordinário nº 658.026/MG, com repercussão geral reconhecida, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 31 de outubro de 2014, foram apontadas cinco condições para a validade de contratação temporária: a) previsão legal dos casos excepcionais; b) prazo de contratação pré-determinado; c) caráter temporário da necessidade; d) excepcionalidade do interesse público; e) indispensabilidade da contratação, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar abrangidos pelas contingências administrativas normais.

No caso do Programa Mais Médicos, os requisitos encontram-se preenchidos. A exigência formal de previsão legislativa foi satisfeita com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

a edição da Medida Provisória nº 621/2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.871/2013. O prazo para o aperfeiçoamento dos médicos participantes e para a concessão do visto temporário dos intercambistas foi pré-fixado em, no máximo, três anos, prorrogável por igual período. Embora sejam permanentes as necessidades envolvendo políticas públicas na área da saúde, a carência de profissionais da área médica em algumas regiões pode ser caracterizada, ao menos em tese, como de caráter temporário, ante as medidas adotadas com a finalidade de formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde – SUS. A excepcionalidade do interesse público está presente na relevância de tais políticas públicas para toda a coletividade. Por fim, a contratação temporária de médicos revela-se indispensável ao adequado atendimento nas regiões com reduzida proporção de médicos por habitantes.

Descabe considerar inconstitucional toda e qualquer contratação temporária voltada ao implemento de atividades essenciais e permanentes. Deve ficar sempre aberta a possibilidade de análise da transitoriedade da situação e da excepcionalidade do interesse público a justificá-la. Esse foi o entendimento do Tribunal, em acórdão assim ementado:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES "NECESSIDADE TEMPORÁRIA" E "EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO". POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição (Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.247/MA, relatora ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de agosto de 2014).
>
> O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. A alegada inércia da administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal" (Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.068, redator do acórdão ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, publicado no Diário da Justiça de 23 de setembro de 2005).

Devem ser observados os direitos dos servidores públicos civis da União assegurados pelo artigo 11 da Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado:

> Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Não procede o alegado desrespeito às exigências constitucionais de concurso público e de licitação, tampouco a direitos sociais dos trabalhadores.

III.3) DA ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

A constitucionalidade dos artigos 3º, 6º e 8º da Medida Provisória nº 621/2013 – correspondentes aos artigos 3º, 10 e 14 da Lei nº 12.871/2013 – é questionada sob o argumento de ofensa ao princípio da autonomia universitária, consagrado no artigo 207 da Lei Maior, o qual dispõe:

> As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A autonomia consiste no poder atribuído a determinadas instituições para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por normas superiores. Nas palavras de José Afonso da Silva, trata-se de "conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder: autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo prefixado."[2]

A autonomia universitária não é irrestrita: subordina-se aos preceitos constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou interpretá-la como independência.

A Constituição Federal, no artigo 22, inciso XXIV, confere à União competência para estabelecer normas gerais sobre a educação nacional, fixando as diretrizes e bases que devem informar o ensino ministrado no

2 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

País. Com alicerce nessa previsão, a Lei nº 9.394/1996, na qual estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, limita a autonomia atribuída às universidades:

> Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
>
> I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
>
> II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
>
> […].

Nos termos do artigo 9º, § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, cabe à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional da Educação "deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação."

O quadro revela a existência de limites legitimamente impostos à autonomia didático-científico, mesmo antes do advento dos dispositivos legais atacados.

No mais, as orientações veiculadas na Lei nº 12.871/2013 estão em harmonia com os parâmetros fixados pelo artigo 214 da Constituição Federal, segundo o qual um dos objetivos do plano nacional de educação consiste em definir diretrizes com o fim de assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas dos poderes públicos voltadas à "formação para o trabalho" e à "promoção humanística".

Quanto a esse ponto, compartilho da visão adotada pelo Procurador-Geral da República, em parecer:

> A formação dos médicos no Brasil tem uma perspectiva humanística, ética e social, que envolve uma reflexão crítica e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

contextualizada, além dos conhecimentos técnico-científicos inerentes à profissão. Desse modo, constata-se que a autonomia universitária para a organização curricular e programática dos cursos de graduação em Medicina já se encontrava limitada pelas diretrizes gerais estabelecidas em 2001 pela Câmara de Educação Superior.

De qualquer forma, nada impede que a União, por meio de medida provisória e respectiva lei de conversão, institua diretrizes curriculares específicas para o curso de Medicina, delegue competências gerenciais ao Ministro da Educação – gestor executivo por excelência da Pasta – e determine a adequação das instituições de ensino superior às novas regras.

Tampouco há violação à gestão democrática do ensino público, prevista no art. 206, VI, da Constituição. A competência estatal para estabelecer diretrizes normativas relativas ao ensino superior decorre do dever do Estado de disciplinar a educação no país, associando-a à realidade social e às políticas públicas. Na hipótese em exame, verifica-se uma política de direcionamento do acesso à saúde para determinadas regiões e públicos-alvo que historicamente foram privados da plena realização desse direito fundamental.

Constatando-se que parte do problema do sistema brasileiro de saúde decorre de deficiências na formação e na distribuição dos médicos no país, é inevitável a integração dos requisitos da formação profissional ao conjunto de soluções desenhadas na política pública posta em ação.

Desse modo, a imposição pelo Estado de novos requisitos curriculares não viola o texto constitucional.

Surge impróprio considerar ofensivas à autonomia universitária as diretrizes fixadas quanto à autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina, à adequação da matriz curricular e ao aperfeiçoamento dos médicos participantes do programa.

III.4) DA DISPENSA DE REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Outro ponto a ser analisado é a dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas. Alega-se que os artigos 13 e 16 da Lei nº 12.871/2013 violam normas da Constituição da República, em especial o princípio da isonomia. Primeiro, por conferir tratamento diferenciado a integrantes de idêntica categoria essencial, qual seja, a dos médicos. Segundo, em razão do atendimento desigual oferecido aos cidadãos brasileiros, conforme a região e a classe econômica. Argumenta-se serem os pacientes de determinados centros urbanos atendidos por profissionais devidamente registrados nos conselhos regionais, ao passo que, nas regiões menos favorecidas, considerada a dispensa de validação dos diplomas, a assistência é realizada por estrangeiros sem a comprovação da capacidade técnica necessária para o adequado exercício da medicina. Daí o risco à vida e à saúde dos pacientes.

O reconhecimento da igualdade pelo direito vem trilhando caminho de constante evolução ao longo da história.

No estado liberal clássico, ocorre em termos meramente formais, no sentido de exigir-se idêntico tratamento a todos que se encontrem na mesma situação, concepção a veicular a ideia de serem todos os homens iguais, não importando o conteúdo do tratamento dispensado nem as condições ou circunstâncias de cada indivíduo. Reduzido ao aspecto formal, o princípio da igualdade converte-se em simples exigência de generalidade e de prevalência da lei em face da jurisdição e da administração. A visão mostrou-se insuficiente para definir quem deveria receber tratamento igual ou desigual e em que medida isso deveria ocorrer.

Com o advento do estado social e o consequente incremento da intervenção estatal em relações sociais, econômicas e culturais, verifica-se releitura do princípio. Ante a constatação de que o mero dever de idêntica proteção para indivíduos ou situações com as mesmas características essenciais acaba por permitir diferenciações arbitrárias e injustas, são delineados os contornos de percepção material, voltada também ao conteúdo justo das normas criadas pelo legislador.[3]

---

3 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

A igualdade material é tradicionalmente associada à clássica definição de Aristóteles: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nesse sentido, a lição de Rui Barbosa segundo a qual "a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam", pois "tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real."[4]

Embora a fórmula aristotélica não forneça critérios substanciais para a formulação de entendimento sobre a relação de igualdade ou de desigualdade, a óptica material pressupõe a adoção de critérios distintivos justos e razoáveis. Nessa perspectiva, o princípio da igualdade é reconduzido à proibição de arbítrio, vedando tratamentos injustificadamente desiguais para situações essencialmente iguais, assim como tratamentos idênticos para casos fundamentalmente desiguais. Vem-nos de grande pensador do Direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, o seguinte trecho:

> O que se visa com o preceito isonômico é impedir favoritismos ou perseguições. É obstar agravos injustificados, vale dizer, que incidam apenas sobre uma classe de pessoas em despeito de inexistir uma racionalidade apta a fundamentar uma diferenciação entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos no Texto Constitucional.[5]

Diversamente de outros direitos fundamentais, a igualdade não possui conteúdo constitucional pré-determinado. Trata-se de conceito relacional a exigir análise comparativa entre situações, indivíduos ou grupos atingidos pela norma.

A intervenção estatal no âmbito da proteção do direito à igualdade ocorre quando os poderes públicos conferem idêntico tratamento a situações distintas ou tratamento desigual a circunstâncias semelhantes.

---

4 BARBOSA, Rui. *Oração aos moços*. São Paulo: Martin Claret, 2003.

5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Compostura jurídica do princípio de igualdade. Revista de Direito Administrativo e Constitucional – AeC. Belo Horizonte, n. 11, Ano 3, Jan./Mar. 2003.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Embora o dever de "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais" não contenha nenhum parâmetro para definir o que é valorativamente igual ou desigual, a igualdade material só se realiza quando adotados critérios justos e razoáveis. Oscar Vilhena Vieira caracteriza o princípio da igualdade como espécie de "regulador das diferenças", atuando para "discernir entre desigualizações aceitáveis e desejáveis e aquelas que são profundamente injustas e inaceitáveis.[6]"

Para ser legítima, a intervenção deve ser constitucionalmente justificada, submetendo-se ao crivo da proporcionalidade, de modo a se revelar adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

A medida estatal é adequada quando apta a fomentar os fins pretendidos. Tal aferição, como ensinam Matthias Klatt e Moritz Meister, deve ser precedida da análise da legitimidade[7]. Em outras palavras: a adequação pressupõe a adoção de meio legítimo capaz de promover objetivo também legítimo.

De acordo com as informações prestadas pela Presidência da República, a contratação de médicos estrangeiros é medida de caráter emergencial e temporário voltada a reduzir a carência de profissionais e as desigualdades regionais na área da saúde. A dispensa de revalidação do diploma é justificada pela restrição do exercício das atividades desses profissionais exclusivamente ao âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, pois a aprovação no Revalida importaria o reconhecimento do direito de exercer livremente a profissão em todo o território nacional, algo contrário à finalidade do projeto.

O meio empregado revela-se ilegítimo por ofender princípios basilares da Constituição da República. O Estado tem o dever de tratar todos os membros da comunidade com idêntico respeito. Nas palavras de Ronald Dworkin, "nenhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos sobre os quais

---

6 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: Uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006.

7 KLATT, Matthias; MEISTER, Moritz. "A máxima da proporcionalidade: um elemento estrutural do constitucionalismo global". Tradução: João Costa Neto. *Observatório da Jurisdição Constitucional*. Brasília: IDP, Ano 7, n. 1, jan./jun. 2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política"[8].

O artigo 196 da Lei Maior estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." A leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em nele reconhecer obrigação constitucional de promoção de políticas públicas abrangentes direcionadas à proteção integral da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível solidariamente aos três entes da Federação. Cabe indagar se a política pública destinada à contratação de médicos estrangeiros sem a devida aferição dos atributos técnicos necessários ao exercício profissional é, à luz desse preceito, suficiente e adequada. A resposta é desenganadamente negativa.

A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover, de maneira constitucional, o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais cuja qualificação técnica, considerada a realidade brasileira, não foi suficientemente avaliada pelos órgãos técnicos competentes. Sob esse ângulo, assim fiz ver em voto proferido no julgamento do recurso extraordinário nº 567.985/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno:

> Embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais o chamado principio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento último radica-se no dever, imputável ao Estado, de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais.

A carência de médicos, embora problema de extrema gravidade, a

8 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: A teoria e a prática da igualdade. Tradução: Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

exigir a adoção de providências concretas por parte das autoridades públicas, não pode servir como justificativa para o comprometimento dos direitos fundamentais em jogo. Da mesma forma estarrece o argumento segundo o qual a revalidação somente é exigível para o médico atuar, indistintamente, em todo o território nacional, como se as regras jurídicas correspondentes não fossem as mesmas, variando conforme a região.

Atentem para a inadequação do ato impugnado ante o princípio da isonomia, consideradas as disparidades regionais do Brasil. Se é certo que a lei atacada visa conferir a estratos mais carentes da sociedade atendimento médico inexistente, combatendo a quebra da igualdade no acesso ao tratamento digno, não é menos correto afirmar a potencialização das disparidades causada pela norma, tendo em vista a prestação de serviços de saúde por médicos submetidos a procedimentos de qualificação destoantes no território nacional.

A título de implementar política pública eficaz em locais não amparados apropriadamente pelo Estado, a Lei nº 12.871/2013 conferiu-lhes assistência médica precária, avaliada em face de parâmetros menos rigorosos em relação àqueles exigidos para o exercício da medicina em outras partes do País. Há de reconhecer-se a afronta ao princípio da isonomia.

O objetivo visado mostra-se ilegítimo, ainda, por contrariar o previsto no inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal, no qual consagrado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Apesar da possibilidade de restrição do exercício profissional pelo legislador ordinário, tem-se, no caso, reserva legal qualificada, por estar a autorização constitucional limitada à eventual imposição de "qualificações profissionais".

Consoante assentado no julgamento do recurso extraordinário nº 511.961/SP, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicado no Diário da Justiça em 13 de novembro de 2009, "o Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que as restrições legais à liberdade de exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Autorizando a norma constitucional situação de reserva legal qualificada, isto é, de restrição a direito fundamental vinculada a certo fim, ausente no caso concreto, a disciplina mostra-se inconstitucional.

No voto proferido no recurso extraordinário nº 603.583/RS, da minha relatoria, Tribunal Pleno, em que debatida questão alusiva às condições impostas para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, fiz ver:

> o constituinte originário limitou as restrições à liberdade de ofício às exigências de qualificação profissional. Cabe indagar: por que assim o fez? Ora, precisamente porque o trabalho, além da dimensão subjetiva, também ostenta relevância que transcende os interesses do próprio indivíduo. Em alguns casos, o mister desempenhado pelo profissional resulta em assunção de riscos os quais podem ser individuais ou coletivos. Quando o risco é predominantemente do indivíduo exemplo dos mergulhadores, dos profissionais que lidam com a rede elétrica, dos transportadores de cargas perigosas, etc., para tentar compensar danos à saúde, o sistema jurídico atribui-lhe vantagens pecuniárias (adicional de periculosidade, insalubridade) ou adianta-lhe a inativação. São vantagens que, longe de ferirem o princípio da isonomia, consubstanciam imposições compensatórias às perdas físicas e psicológicas que esses profissionais sofrem.
>
> Quando, por outro lado, o risco é suportado pela coletividade, então cabe limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício, exatamente em função do interesse coletivo. Daí a cláusula constante da parte final do inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal, de ressalva das qualificações legais exigidas pela lei. Ela é a salvaguarda de que as profissões que representam riscos à coletividade serão limitadas, serão exercidas somente por aqueles indivíduos conhecedores da técnica.
>
> A alusão à dignidade da pessoa humana há de ser lida sob esse prisma, não se devendo levar o princípio às últimas consequências. [...] A liberdade de profissão não se resume à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> esfera particular. Certas profissões, como as de médico, engenheiro, arquiteto, se exercidas por pessoas despidas das qualificações técnicas necessárias, podem resultar em graves danos à coletividade.

A lei atacada, ao dispensar a revalidação do diploma com a alegada restrição do exercício profissional ao âmbito do projeto, subverte a finalidade da cláusula limitadora. Vale dizer: em vez de limitar o acesso à profissão e o exercício com o intuito de prevenir os riscos trazidos à coletividade pela atuação de profissionais médicos inabilitados, optou-se por flexibilizar os critérios de avaliação das qualificações técnicas necessárias ao exercício da medicina no âmbito do programa, ampliando os potenciais danos à vida e à saúde dos pacientes atendidos pelos médicos intercambistas.

Ainda que o meio seja apto a fomentar o fim almejado, ambos carecem de legitimidade à luz da Constituição. Por não superada a etapa da adequação, faz-se desnecessária a análise da exigibilidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

III.5) DO TRATAMENTO CONFERIDO AOS MÉDICOS CUBANOS

Analise-se a questão referente ao tratamento diferenciado conferido aos profissionais da classe médica participantes do programa.

O artigo 23 da Lei nº 12.871/2013 autoriza os Ministérios da Educação e da Saúde, com o propósito de executar as ações relacionadas ao programa, a firmar acordos e outros instrumentos de cooperação, inclusive com organismos internacionais.

Buscando viabilizar o "PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", o Ministério da Saúde celebrou o Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica, que tem por objeto a inserção de metas e recursos para garantir a cooperação técnica entre as partes. Para o desenvolvimento das atividades do programa, previu:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> I – Compete ao MINISTÉRIO, em conformidade com suas políticas, normas e regulamentos:
>
> [...]
>
> o) Realizar, com base nos Planos de Ação do PROGRAMA, o repasse semestral antecipado à OPAS/OMS dos recursos referentes:
>
> i) ao financiamento da cooperação técnica prestada pela OPAS/OMS, incluída a cooperação por meio de consultores e assessores em Atenção Básica em Saúde;
>
> ii) ao financiamento das bolsas dos Médicos Participantes, incluídas as ajudas de custo de instalação, definido pela Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, assim como o transporte internacional dos Médicos Participantes (incluído o transporte por recesso) e o seguro de vida com repatriação por morte.
>
> [...]

Surge o seguinte quadro: os médicos formados em instituições brasileiras de ensino superior ou com diplomas revalidados recebem valores integrais, correspondentes ao que rotulado como bolsa e ajuda de custo, depositados diretamente em conta-corrente. Já o pagamento da remuneração dos médicos cubanos contratados por meio do referido convênio é efetuado de forma indireta, mediante o repasse dos valores pela Organização Pan-americana da Saúde – OPAS ao governo de Cuba, que retém determinada parcela oficialmente não revelada.

Os valores sociais do trabalho são um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o artigo 1º, inciso IV, do Texto Maior. Da opção política feita pelo constituinte originário resulta compromisso inafastável do Estado brasileiro com a valorização do ser humano, a refletir o reconhecimento do direito ao trabalho como desdobramento da dignidade, uma vez que "é por meio do trabalho que o homem atinge sua plenitude, realiza sua própria existência, socializa-se,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

exercita todas as suas potencialidades (materiais, morais e espirituais)." Daí a assertiva de Cláudio Mascarenhas Brandão no sentido de o referido fundamento representar "a projeção do princípio da proteção à dignidade do homem na condição de trabalhador."[9]

No mesmo sentido, ensina o professor José Afonso da Silva:

> Os *valores sociais do trabalho* estão precisamente na sua função de criar riquezas, de prover a sociedade de bens e serviços e, enquanto atividade social, fornecer à pessoa humana bases de sua autonomia e condições de vida digna. Os *valores do trabalho*, portanto, só se materializam com o direito à livre escolha do trabalho pelo trabalhador, direito a condições equitativas (igualdade de tratamento nas relações de trabalho), direito a uma remuneração que assegure ao trabalhador e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana do trabalhador e seus familiares[10].

Como acontece com os princípios fundamentais, os quais encampam valores supremos densificados ao longo do texto constitucional, trata-se de norma politicamente conformadora, vinculante para os poderes públicos, a ser observada como vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico.

O tratamento conferido aos médicos cubanos viola, a mais não poder, direitos sociais assegurados aos trabalhadores, notadamente a proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, contida no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.

A vedação tem como finalidade impedir diferenciações injustificadas, prejudiciais à vida econômica do trabalhador. A regra geral – corolária, na esfera das relações de trabalho, da cláusula pétrea da igualdade –, consagra rol aberto, e não taxativo, de modo a alcançar

---

9 BRANDÃO, Cláudio Mascarenhas. "Comentário ao artigo 1º, inciso IV". *Comentários à Constituição do Brasil*. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 128-132.

10 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

outros motivos que possam ensejar tratamentos indevidamente diferenciados, entre eles a origem ou nacionalidade do trabalhador.

Nesse sentido, transcrevo parte do voto do ministro Néri da Silveira quando do exame do recurso extraordinário nº 161.243, relator ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 1997:

> De outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso XXX do art. 7º da CF, qualquer discriminação decorrente – além, evidentemente, da nacionalidade – de sexo, idade, cor ou estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário a tratamento discriminatório entre pessoas que prestam serviços iguais a um empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou.

A vedação constitucional dirige-se não apenas aos particulares, mas também ao próprio Estado, de forma que distinções envolvendo remuneração, exercício de funções e critério de admissão somente são consideradas legítimas quando razoáveis e passíveis de justificação pela natureza das atribuições a serem exercidas. É essa a diretriz hermenêutica contida no verbete nº 683 da Súmula deste Tribunal:

> O limite de idade para a inscrição em concurso só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A obscuridade envolvendo os termos do acordo firmado entre a Organização Pan-americana da Saúde – OPAS e o governo cubano, reiteradamente destacada durante a audiência pública[11], e o tratamento

11 O titular da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves, afirmou: "Por várias vezes, nós solicitamos da OPAS que nos desse detalhes ou, senão pelo menos, a cópia do contrato. Eles sequer aceitaram ir ao Congresso Nacional." No mesmo sentido, Sebastião

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

conferido aos profissionais contratados por intermédio do mencionado convênio também não se coadunam com o preceituado no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da Organização Mundial da Saúde – OMS:

> 3.5. O recrutamento internacional de pessoal de saúde deve ser conduzido de acordo com os princípios da transparência, justiça e promoção da sustentabilidade dos sistemas de saúde de países em desenvolvimento. Estados-Membros, em conformidade com a legislação nacional e instrumentos legais internacionais aplicáveis, devem promover e respeitar práticas trabalhistas justas para todo o pessoal de saúde. Todos os aspectos do trabalho e do tratamento do pessoal de saúde imigrante devem ser tratados sem nenhuma distinção ilegal de qualquer tipo.
>
> […]
>
> 4.4. Os Estados-Membros devem, na extensão possível das leis aplicáveis, garantir que os recrutadores e empregadores observem práticas justas de recrutamento e contrato no emprego de pessoal de saúde imigrante e que este não sejam objeto de condutas ilegais ou fraudulentas. O pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tais como níveis de qualificação, anos de experiência e grau de responsabilidade baseados na igualdade de tratamento com o pessoal de saúde do país.

Vieira Caixeta, procurador do Ministério Público do Trabalho, ressaltou: "Foi-nos trazida inclusive a argumentação da União a respeito de que essa relação – e não há controvérsia a respeito disso – dos profissionais cubanos que não percebem a bolsa de dez mil reais, como tal ocorre em relação aos demais profissionais, sejam eles nacionais ou estrangeiros – estrangeiros de outras nacionalidades que não aqueles oriundos de Cuba recebem –, observados os parâmetros da própria medida provisória convertida em lei, os dez mil reais referentes à bolsa, o dinheiro é repassado, através de um convênio celebrado entre Brasil e a OPAS, a Cuba. E aí eu até procurei obter acesso à outra parte do convênio, que fecha essa negociação, que é o convênio entre a OPAS e o Governo de Cuba, e não tive acesso. Foi formalmente negado o acesso a esse convênio. Aliás, segundo informações, sequer o Governo brasileiro tem acesso a esse convênio para saber como é feita a disciplinação do pagamento desses direitos, o que nos parece importante de saber, de maneira a deixar de forma clara o que deve ser repassado aos profissionais."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

> Recrutadores e empregadores devem prover o pessoal de saúde imigrante de informações relevantes e precisas sobre todas as posições oferecidas.
>
> 4.5. Os Estados-Membros devem garantir que, sujeitos às leis aplicáveis, incluindo instrumentos legais internacionais, o pessoal de saúde imigrante deve possuir os mesmos direitos legais e responsabilidades que o pessoal de saúde do país no que concerne a todos os termos de contratação e às condições de trabalho.
>
> […]

As diretrizes fixadas pelo Código devem ser respeitadas pelo Estado brasileiro, inclusive no tocante à seleção de médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, como enfatizado na exposição de motivos da Medida Provisória nº 621/2013:

> 35. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de informações, o monitoramento e a pesquisa no tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arco-Sur.

O pagamento indireto e a menor contraria a Convenção nº 117 sobre objetivos e normas básicas da política social, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho – OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 65/1966 e incorporada ao ordenamento jurídico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

brasileiro por meio do Decreto nº 66.429/1970:

> ARTIGO 8º
>
> 1 - Quando numa região se apelar para os recursos de mão de obra de um país submetido a uma administração diferente, as autoridades competentes dos países interessados deverão, sempre que for necessário ou desejável fazê-lo, concluir acordos para solucionar as questões de interesse comum que possam ser levantadas pela aplicação das disposições da presente Convenção.
>
> 2 - Esses acordos deverão providenciar para que o trabalhador migrante goze de uma proteção e de vantagens não inferiores àquelas de que beneficiam os trabalhadores residentes na região do emprego.
>
> [...]
>
> ARTIGO 11
>
> 1 - Tomar-se-ão as medidas necessárias para assegurar que todos os salários ganhos sejam devidamente pagos, e os empregadores terão obrigatoriamente de estabelecer registros que indiquem os pagamentos dos salários, de entregar aos trabalhadores atestados relativos ao pagamento dos seus salários e de tomar outras medidas apropriadas para facilitar a inspeção necessária.
>
> 2 - Os salários não serão normalmente pagos senão em moeda com circulação legal.
>
> 3 - Os salários serão normalmente pagos diretamente ao próprio trabalhador.

O tratamento dado aos médicos cubanos, especialmente no tocante à contraprestação remuneratória indireta e não integral, por se mostrar nitidamente incompatível com os direitos sociais básicos assegurados aos trabalhadores, merece a glosa jurisdicional.

IV) DO DISPOSITIVO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

Ante o quadro, não admito as ações diretas relativamente aos artigos 15, § 1º, III, e 16, parágrafos 2º a 4º, da Lei nº 12.871/2013; julgo prejudicado o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF quanto aos artigos 4º e 5º da referida lei; e defiro parcialmente os pedidos formalizados em relação aos demais dispositivos, assentando a inconstitucionalidade dos artigos 13, II, § 1º, II e III, e § 2º, II, e 16 da Lei nº 12.871/2013 e, por arrastamento, do Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e a Organização Pan-americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185534.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, inicialmente queria parabenizar o Ministro Marco Aurélio pela excelência do voto e o detalhamento, que vai facilitar o meu voto.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Ministro, tenho muito receio quando se começa a elogiar: quando se elogia o advogado é porque se vai votar contra o constituinte. Vossa Excelência começou a me elogiar. Já estou com o pé atrás.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Como o Ministro Marco Aurélio colocou, a ADI 5.037 é mais ampla do que a ADI 5.035. E isso é muito importante em relação às questões que irei apontar separadamente, porque a ADI 5.035 é mais restrita do que a 5.037, que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários e Regulamentados - CNTU. Enquanto a CNTU impugnou do artigo 3º até o artigo 14 da Medida Provisória - que agora seria, na verdade, com adaptações até o 20 -, a ADI 5.035 é mais restrita, a impugnação é específica aos artigos 3º, 7º, dois incisos e parágrafos 9º; 10º e 11º.

Senhora Presidente, trago isso porque, preliminarmente, não conheço da legitimidade da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários e Regulamentados - CNTU.

Não reconheço legitimidade a essa Confederação, como já defendi aqui em outras oportunidades, porque entendo que permanece a ideia de análise da pertinência temática do artigo 103 - artigo com maior número de legitimados de qualquer constituição. Ou seja, a ampla possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, a partir de 1988 é maior do que em qualquer país e resolveu a falha da legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para representação de inconstitucionalidade, que era somado ao problema de ausência de independência em relação ao Poder Executivo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587251.

Mas aqui, além da ausência de pertinência temática, a CNTU, por decisão judicial, teve invalidado o seu registro sindical. Em 22 de março de 2017, como apontado pelo eminente Decano, Ministro Celso de Mello, ao julgar extinta a ADI nº 4.380 por perda superveniente da legitimidade ativa *ad causam*.

Há outros precedentes, e não me estenderei. A decisão judicial de nulidade do registro sindical foi confirmada pelo TST. Ou seja, além de não haver a pertinência temática, não há nem a existência legal da própria Confederação.

Presidente, no caso da ADI 5.037, voto no sentido da falta de legitimidade e sua consequente extinção.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Então, Vossa Excelência vota no sentido de não conhecer. Neste caso, o voto do Ministro-Relator considera o objeto das duas ADIs, sendo mais amplo, conforme colocado pelo Ministro desde o início, o da Ação Direta nº 5.037.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Apenas torno a frisar que julgo a situação concreta de acordo com os elementos contidos no processo. Não faço investigações outras!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Considerando este dado, Vossa Excelência julga pelo não conhecimento neste caso. E vai exarar, portanto, o voto de Vossa Excelência na Ação Direta nº 5.035. O caso seria, então, de colher os votos até para ouvir o voto de Vossa Excelência se superado este caso quanto à 5.037.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Se superado, farei a análise geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587251.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, eminente Ministro-Relator desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ministro Marco Aurélio, Ministro Alexandre de Moraes, que acaba de suscitar essa preliminar de incognoscibilidade da ADI nº 5.037, de ilegitimidade ativa da Confederação. É isso, Ministro?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Vossa Excelência me permite, Ministro?

Na verdade, ele não suscitou. O Ministro-Relator suscitou, enfrentou e superou. E o Ministro Alexandre de Moraes está divergindo nesta preliminar para extinguir o processo. A preliminar foi longamente suscitada pelo Ministro-Relator, e diverge no ponto logo de início, por isso estou tomando, a partir de agora, separadamente, a preliminar.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - É que o segundo fundamento que o Ministro Alexandre traz, a rigor, é um fundamento novo, mas a preliminar, seguramente, quanto à pertinência temática.

E eu depreendo, Senhora Presidente, que há dois fundamentos na manifestação na questão da legitimidade. O primeiro, da ausência de pertinência temática, e o segundo, da ausência de regular registro sindical.

Em relação ao primeiro, eu peço todas as vênias ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. Entendo que o eminente Ministro-Relator, em meu modo de ver, na expressão de Sua Excelência, a que estou aqui dando o devido crédito, evidenciou a mais não poder a pertinência temática dessa Confederação com o tema que está sendo objeto de desate. Portanto, neste ponto, peço vênia ao Ministro Alexandre, para não acompanhar esta preliminar, digamos assim, que Sua Excelência traz a este Colegiado. E subscrevo todos os argumentos do eminente Ministro-Relator, que, aliás, revisitou, inclusive, jurisprudência desta Corte. E, nessa revisita, compôs uma latitude hermenêutica, em meu modo de ver,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587252.

de uma fundamentação racional e sistemática que me conforta completamente.

Já quanto ao segundo fundamento, aqui, sim, eu vejo, o que traz o Ministro Alexandre, um problema, porque, efetivamente, na ADI nº 4.380, o eminente Ministro-Decano, Ministro Celso de Mello, assentou a ausência por perda superveniente de legitimidade processual dessa mesma Confederação. E essa decisão transitou em julgado.

Além disso, depreendo que também, em sede de Agravo no Recurso Extraordinário nº 919.995, e pelo que tenho aqui, à verificação da relatoria de Vossa Excelência, Ministra-Presidente, julgado em 1º de dezembro de 2015, publicado em 10 de dezembro de 2015, a declaração de nulidade do registro sindical da autora desta ADI nº 5.037 foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, decisão essa, a seu turno, mantida em decisão posterior, da lavra de Vossa Excelência, deste Supremo Tribunal Federal.

Portanto, em relação ao segundo fundamento, colocada essa realidade, eu a vejo, com todas as vênias aqui dos entendimentos diversos, como, de fato, intransponível e, com esse segundo fundamento, eu acompanho o Ministro Alexandre de Moraes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587252.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS - CNTU
ADV.(A/S)	: JONAS DA COSTA MATOS
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL DRª MAÍRA FACHINI - AMN-MF
ADV.(A/S)	: DOUGLAS BORGES DE VASCONCELOS

V O T O - V O G A L

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado relatório proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio.

Assento, preliminarmente, a plena cognoscibilidade da ação direta autuada sob n. 5.035. A autora detém legitimidade para a iniciativa do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da CRFB, conforme já assentou este Tribunal quando do julgamento da ADI-MC 5.501, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.07.2017.

No que tange à ADI 5.037, a entidade autora "Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU" não ostenta legitimidade ativa para a propositura da ação.

Com efeito, nos termos do art. 103, IX, da CRFB, detêm legitimidade para a propositura "confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional".

Ao interpretar esse dispositivo, este Tribunal tem exigido que a confederação sindical deve apresentar duplo registro, ou seja, não basta apenas o registro civil, no respectivo cartório de pessoas jurídicas, é preciso, ainda, o registro sindical no Ministério do Trabalho.

Ocorre, porém, que, por meio de decisão do Tribunal Regional do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Trabalho da 10ª Região, foi declarada a nulidade do registro sindical da autora, decisão que, posteriormente foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho e por este Supremo Tribunal Federal (ARE 919995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/12/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09/12/2015 PUBLIC 10/12/2015).

Mais recentemente, o e. Ministro Celso de Mello proferiu decisão monocrática na ADI 4.380 reconhecendo a perda superveniente da legitimidade processual da mesma entidade autora da ADI 5.037. Deve-se consignar que tal decisão transitou em julgado em 21.04.2017.

Por essa razão, a ausência do duplo registro é razão impeditiva para o conhecimento da ADI 5.037, ante a ilegitimidade da confederação requerente.

No que se refere à conversão da medida provisória em lei, o que, na linha de precedentes desta Corte, poderia dar ensejo à perda de objeto da ação direta, é preciso registrar que, por meio da Petição 14357/2015, houve pedido de aditamento a fim de que, no que tange às impugnações de ordem material, seja reconhecido o interesse da autora na continuidade do julgamento. Não há, portanto, impedimento para que a ação possa ter continuidade.

A Associação Médica Brasileira argui a inconstitucionalidade da MP 621/13 convertida na Lei 12.871. A norma tem o seguinte teor:

> "CAPÍTULO I
> DISPOSIÇÕES GERAIS
> Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos:
> I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;
> II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País;
> III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

processo de formação;

IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;

V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;

VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;

VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS; e

VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações:

I - reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos;

II - estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e

III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE MEDICINA

Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de Medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Lei.

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que:

I - possuam certificação como hospitais de ensino;

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus serviços.

§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde.

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I - os seguintes critérios de qualidade:

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas;

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:

a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na região;

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza.

CAPÍTULO III

DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo constitui ponto de auditoria nos processos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

avaliativos do Sinaes.

Art. 5º Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos cursos de graduação em Medicina do ano anterior.

Parágrafo único. A regra de que trata o caput é meta a ser implantada progressivamente até 31 de dezembro de 2018.

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5º, será considerada a oferta de vagas de Programas de Residência Médica nas seguintes modalidades:

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; e

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes especialidades:

a) Genética Médica;

b) Medicina do Tráfego;

c) Medicina do Trabalho;

d) Medicina Esportiva;

e) Medicina Física e Reabilitação;

f) Medicina Legal;

g) Medicina Nuclear;

h) Patologia; e

i) Radioterapia.

Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade terá duração mínima de 2 (dois) anos.

§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade será obrigatório para o ingresso nos seguintes Programas de Residência Médica:

I - Medicina Interna (Clínica Médica);

II - Pediatria;

III - Ginecologia e Obstetrícia;

IV - Cirurgia Geral;

V - Psiquiatria;

VI - Medicina Preventiva e Social.

§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Comunidade para os demais Programas de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de Residência Médica de acesso direto.

§ 3º O pré-requisito de que trata este artigo apenas será exigido quando for alcançada a meta prevista no parágrafo único do art. 5º, na forma do regulamento.

§ 4º Os Programas de Residência Médica estabelecerão processos de transição para implementação, integração e consolidação das mudanças curriculares, com o objetivo de viabilizar a carga horária e os conteúdos oferecidos no currículo novo e permitir o fluxo na formação de especialistas, evitando atrasos curriculares, repetições desnecessárias e dispersão de recursos.

§ 5º O processo de transição previsto no § 4º deverá ser registrado por meio de avaliação do currículo novo, envolvendo discentes de diversas turmas e docentes.

§ 6º Os Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade deverão contemplar especificidades do SUS, como as atuações na área de Urgência e Emergência, Atenção Domiciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde Coletiva e Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida.

§ 7º O Ministério da Saúde coordenará as atividades da Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade no âmbito da rede saúde-escola.

Art. 8º As bolsas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade poderão receber complementação financeira a ser estabelecida e custeada pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

Art. 9º É instituída a avaliação específica para curso de graduação em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do Ministro de Estado da Educação.

§ 1º É instituída avaliação específica anual para os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Programas de Residência Médica, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, pela CNRM.

§ 2º As avaliações de que trata este artigo serão implementadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do sistema federal de ensino.

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da matriz curricular para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao Ministro de Estado da Educação.

Art. 11. A regulamentação das mudanças curriculares dos diversos programas de residência médica será realizada por meio de ato do Ministério da Educação, ouvidos a CNRM e o Ministério da Saúde.

Seção Única

Do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde

Art. 12. As instituições de educação superior responsáveis pela oferta dos cursos de Medicina e dos Programas de Residência Médica poderão firmar Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, na qualidade de gestores, com a finalidade de viabilizar a reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas de Residência Médica e a estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade, além de permitir a integração ensino-serviço na área da Atenção Básica.

§ 1º O Contrato Organizativo poderá estabelecer:

I - garantia de acesso a todos os estabelecimentos assistenciais sob a responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência médica; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

II - outras obrigações mútuas entre as partes relacionadas ao funcionamento da integração ensino-serviço, cujos termos serão levados à deliberação das Comissões Intergestores Regionais, Comissões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, ouvidas as Comissões de Integração Ensino-Serviço.

§ 2º No âmbito do Contrato Organizativo, caberão às autoridades mencionadas no caput, em acordo com a instituição de educação superior e os Programas de Residência Médica, designar médicos preceptores da rede de serviços de saúde e regulamentar a sua relação com a instituição responsável pelo curso de Medicina ou pelo Programa de Residência Médica.

§ 3º Os Ministérios da Educação e da Saúde coordenarão as ações necessárias para assegurar a pactuação de Contratos Organizativos da Ação Pública Ensino-Saúde.

CAPÍTULO IV

DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

da Medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à sua aprovação nas avaliações periódicas.

§ 3º O primeiro módulo, designado acolhimento, terá duração de 4 (quatro) semanas, será executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da Atenção Básica em saúde, aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Ministério da Saúde, à língua portuguesa e ao código de ética médica.

§ 4º As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e compreenderão o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o médico participante está apto ou não a continuar no Projeto.

§ 5º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas avaliações de que tratam os §§ 1º a 4º, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a programação em módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

§ 3º A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, para todos os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão médica e à tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(Vide Decreto nº 8.126, de 2013) (Vide Lei nº 13.333, de 2016)

§ 1º (VETADO).

§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.

§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de registro único.

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto.

(Vide Lei nº 13.333, de 2016)

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o caput aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, na forma da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os médicos intercambistas:

I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou

II - filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.

Art. 21. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil que descumprirem o disposto nesta Lei e nas normas complementares:

I - advertência;

II - suspensão; e

III - desligamento das ações de aperfeiçoamento.

§ 1º Na hipótese do inciso III do caput, poderá ser exigida a restituição dos valores recebidos a título de bolsa, ajuda de custo e aquisição de passagens, acrescidos de atualização monetária, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º Na aplicação das penalidades previstas neste artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 3º No caso de médico intercambista, o desligamento do Programa implicará o cancelamento do registro único no Ministério da Saúde e do registro de estrangeiro.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, a coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil comunicará o desligamento do médico participante ao CRM e ao Ministério da Justiça.

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

§ 1º As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço.

§ 2º O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.

§ 3º A pontuação adicional de que trata o § 2º não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2º deste artigo.

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei.

§ 5º Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com transferência de recursos.

Art. 24. São transformadas, no âmbito do Poder Executivo, sem aumento de despesa, 117 (cento e dezessete) Funções Comissionadas Técnicas (FCTs), criadas pelo art. 58 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, do nível FCT-13, em 10 (dez) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo 2 (dois) DAS-5 e 8 (oito) DAS-4.

Art. 25. São os Ministérios da Saúde e da Educação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

autorizados a contratar, mediante dispensa de licitação, instituição financeira oficial federal para realizar atividades relacionadas aos pagamentos das bolsas de que trata esta Lei.

Art. 26. São a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) autorizados a conceder bolsas para ações de saúde, a ressarcir despesas, a adotar outros mecanismos de incentivo a suas atividades institucionais e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do Programa Mais Médicos, observada a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

Art. 27. Será concedida bolsa para atividades de preceptoria nas ações de formação em serviço nos cursos de graduação e residência médica ofertados pelas instituições federais de educação superior ou pelo Ministério da Saúde.

§ 1º Integram as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção de que trata o § 4º do art. 12 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a serem estabelecidas em ato do Ministério da Educação, o exercício profissional no SUS, na área de docência do professor, a preceptoria de que trata esta Lei e o exercício de atividade nos programas definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde.

§ 2º Com vistas a assegurar a universalização dos programas de residência médica prevista no art. 5º desta Lei, poderão ser adotadas medidas que ampliem a formação de preceptores de residência médica.

Art. 28. Os médicos participantes e seus dependentes legais são isentos do pagamento das taxas e dos emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, e no Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de janeiro de 1985.

Art. 29. Para os efeitos do art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, os valores percebidos a título de bolsa previstos nesta Lei e na Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, não caracterizam contraprestação de serviços.

Art. 30. O quantitativo dos integrantes dos projetos e programas de aperfeiçoamento de que trata esta Lei observará

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

os limites dos recursos orçamentários disponíveis.

§ 1º O quantitativo de médicos estrangeiros no Projeto Mais Médicos para o Brasil não poderá exceder o patamar máximo de 10% (dez por cento) do número de médicos brasileiros com inscrição definitiva nos CRMs.

§ 2º O SUS terá o prazo de 5 (cinco) anos para dotar as unidades básicas de saúde com qualidade de equipamentos e infraestrutura, a serem definidas nos planos plurianuais.

§ 3º As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos nesta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias destinadas aos Ministérios da Educação, da Defesa e da Saúde, consignadas no orçamento geral da União.

Art. 31. Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde poderão editar normas complementares para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 32. A Advocacia-Geral da União atuará, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, na representação judicial e extrajudicial dos profissionais designados para a função de supervisor médico e de tutor acadêmico prevista nos incisos II e III do art. 15.

Art. 33. A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o .....

.....

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.

…."

(NR)

"Art. 4o .....……..... …..

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> .....
>
> IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2o desta Lei;
>
> ,,,.....
>
> Parágrafo único. .....
>
> .....
>
> V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos; e
>
> ....." (NR)
>
> Art. 34. O art. 1o da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3o, 4o e 5o:
>
> "Art. 1o .....
>
> .....
>
> § 3o A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil.
>
> § 4o As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
>
> § 5o As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo deverão encaminhar, anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as ações de saúde pública." (NR)
>
> Art. 35. As entidades ou as associações médicas que até a data de publicação desta Lei ofertam cursos de especialização não caracterizados como Residência Médica encaminharão as relações de registros de títulos de especialistas para o Ministério da Saúde, para os fins previstos no § 5º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981.
>
> Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

No que tange ao vício formal alega pela inicial relativo aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

pressupostos de relevância e urgência, não há, na medida inquinada, traço de inconstitucionalidade a ser reconhecido por esta Corte.

Tem-se que a Medida Provisória é espécie normativa de competência exclusiva do Presidente da República e excepcional, pois sujeita às exigências de relevância e urgência.

Editada a Medida Provisória, compete ao Poder Legislativo realizar o seu controle. Frise-se que este último é, a um só tempo, político e jurídico, pois se debruça sobre a análise das circunstâncias (urgência e relevância) exigidas pela própria Constituição para a sua edição. Nesse sentido é o magistério de Clève Clèmerson Merlin:

> "O controle parlamentar assume dupla dimensão: é político e jurídico, a um só tempo. A atividade do legislativo não é absolutamente livre, circunscrevendo-se às diretrizes, normas e princípios aprovados pelo Constituinte. Por isso, o Congresso Nacional haverá de formular juízo político, mas também jurídico, no tocante à admissibilidade (concretização dos pressupostos de edição) da medida provisória. É inegável que, nesse particular, a dimensão política do controle vai prevalecendo sobre a jurídica. Superada esta fase e apreciado o conteúdo da medida provisória desde a perspectiva de sua compatibilidade com a Constituição, os critérios da conveniência e oportunidade orientarão a manifestação congressual (conversão ou rejeição). Aliás, a constitucional é questão prejudicial desta. Nesse ponto, a apreciação do Congresso não deve ser mais do que jurídica. Havendo a compatibilidade da matéria disciplinada pela medida com a Lei Fundamental, superada a questão prejudicial, o Parlamento estará livre par apreciar politicamente o ato legislativo provisório." (CLÈVE, Clèmerson Merlin. *Medidas Provisórias*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.183-185).

Sob essas lentes, cumpre observar que apesar da inviabilidade da convalidação, pela lei de conversão, de eventuais inconstitucionalidades da medida provisória, no caso em apreço não se está diante de hipótese

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

de inconstitucionalidade formal à exigir intervenção judicial.

É verdade que a jurisprudência desta Corte evoluiu quanto o controle judicial dos requisitos de urgência e relevância das medidas provisórias, mas ressaltou que tal controle só pode ser exercido em situações excepcionais.

Sobre a evolução do controle judicial dos pressupostos de edição de MP, esclarece o e. Relator, Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento do RE 592.377, Redator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015, Tema 33 da Repercussão Geral:

> "Em um primeiro momento, o entendimento foi de admiti-lo apenas em casos de "excesso do poder de legislar", devendo ficar a apreciação por conta, em princípio, do Chefe do Poder Executivo e do Congresso Nacional (Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 162, da relatoria do ministro Moreira Alves, julgada em 14 de dezembro de 1989, Diário da Justiça de 19 de setembro de 1997). Sem dúvida, a óptica, se não incentivou, ao menos não impediu a reedição indefinida das medidas provisórias, de início com números diversos e, após, mediante repetição numérica seguida de dígito a revelar o número da reedição. Aos poucos, o Tribunal, em face dos abusos a demonstrarem a usurpação da atividade do Poder Legislativo, intensificou o controle de constitucionalidade dos pressupostos contidos na cabeça do artigo 62 da Carta, minimizando o caráter de "questões políticas" e passando a assentar inconstitucionais medidas carentes de urgência e relevância. Ao apreciar, em 16 de abril de 1998, o pedido liminar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.753/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence – acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de junho de 1998 –, o Plenário, por unanimidade, suspendeu a eficácia de dispositivos da Medida Provisória nº 1.577-6, de 1997, por afronta ao aludido artigo 62. Na ocasião, fiz ver:
>
> Os predicados da relevância e da urgência estão previstos no artigo 62 da Constituição Federal, de que esta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> Corte é guarda como um grande todo. Logo, cabe-lhe perquirir - e se admite, até mesmo, o controle de atos discricionários quanto ao motivo, à finalidade, à razão da prática - se, na espécie, concorreram, ou não, esses dois requisitos previstos no artigo 62 da Constituição Federal. E a toda evidência não concorreram.
>
> Atualmente, não mais existe oscilação na jurisprudência do Tribunal a respeito da possibilidade de controle de constitucionalidade das medidas provisórias sob o ângulo do atendimento aos requisitos do artigo 62 – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.736/DF, relator ministro Cezar Peluso, julgada em 8 de setembro de 2010, Diário da Justiça de 29 de março de 2011."

Embora tenham os demais integrantes do Colegiado aquiescido quanto a esse fundamento, o Tribunal, quando do julgamento de mérito, acompanhou o voto do saudoso Ministro Teori Zavascki que, em sua manifestação, sublinhou a excepcionalidade do controle a ser exercido pela Corte:

> "Por ora, não está em debate a questão de mérito da medida provisória. Até porque, quanto à sua higidez material, o Supremo Tribunal Federal considerou que não havia inconstitucionalidade nas disposições normativas que estabeleciam para o sistema financeiro critérios de remuneração diferentes dos da Lei de Usura. Há súmula do Tribunal no tema (Súmula 648/STF), e a controvérsia suscitou, inclusive, uma discussão fértil a respeito da cobrança da comissão de permanência.
>
> O que subsiste, aqui, como argumento fundamental, é a falta dos requisitos de relevância e urgência da matéria. Esse é o tema fundamental. Como bem ressaltou o Ministro Relator, o Supremo Tribunal Federal considera sindicável, pelo Poder Judiciário, a presença ou não desses requisitos. Isso porque a invocação vazia desses parâmetros, antes de justificar a atuação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> da Presidência da República no campo da normatividade primária, revela exercício abusivo de prerrogativa política. Todavia, os precedentes da Corte têm enfatizado que o escrutínio a ser feito pelo Judiciário neste particular é de domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal desses requisitos. É o que ficou proclamado, por exemplo, na ADI 4350, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/14; na ADC 11 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 29/6/07; e na ADI´s 1910 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/2/04."

Ou seja, apesar da jurisprudência deste Tribunal ter se consolidado no sentido da possibilidade de controle judicial dos pressupostos para a edição de medidas provisórias, "o Poder Judiciário deve reconhecer a inconstitucionalidade de texto de medida provisória que, de forma inquestionável, se afaste dos requisitos de relevância e urgência" (ADI 4.350, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03.12.2014).

A forma de se realizar esse controle deve depender da motivação apresentada pelo Chefe do Poder Executivo. Como indica Clèmerson Merlin Clève, a motivação, embora não seja requisito constitucional expresso, facilita o controle da legitimidade e dos requisitos constitucionais autorizadores, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário.

Não estão presentes, *in casu*, tais requisitos.

Acolhendo a ressalva feita por Clèmerson Merlin Clève, é preciso advertir que os conceitos de relevância e urgência não são, a rigor, passíveis de completa definição *a priori* (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 88). Nada obstante, ainda na esteira da lição do Professor da Universidade Federal do Paraná:

> "Possui relevância aquilo que é importante, proeminente, essencial, exigível, fundamental ou indispensável. Quanto às medidas provisórias, a relevância demandante de sua adoção não comporta satisfação de interesses outros que não os da sociedade. A relevância há, portanto, de vincular-se unicamente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> à realização de um interesse público.
>
> De outro ângulo, a relevância autorizadora da deflagração da competência normativa do Presidente da República não se confunde com a ordinária, desafiadora do processo legislativo comum. Trata-se, antes, de relevância extraordinária, excepcional, especialmente qualificada, contaminada pela contingência, acidentalidade, imprevisibilidade."
>
> (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 89-90).

Do ponto de vista da relevância é preciso realçar que a prioridade atribuída ao tema pelo constituinte é evidente:

> "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."
>
> (...)
>
> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
>
> Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado."

Não por outra razão, a matéria é de competência comum de todos os entes federados (art. 23, II, CRFB).

A jurisprudência desta Corte tem, por sua vez, reconhecido que o tema é da mais alta relevância para o país, como destacou, por exemplo, o e. Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento da ADPF 54, Pleno, DJe

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

29.04.2013. De modo mais específico, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do MS 32.238, fez consignar que o programa instituído pela medida provisória "configura uma política pública da maior importância social, sobretudo ante a comprovada carência de recursos humanos na áreas médica no âmbito do Sistema Único de Saúde".

Na exposição de motivos da medida impugnada nesta ação direta, é possível depreender que as preocupações externadas pelos órgãos do Poder Executivo vão ao encontro da relevância outorgada pelo constituinte ao direto fundamental à educação:

> "1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Medida Provisória que institui o Programa Mais Médicos, com a finalidade de:
>
> I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;
>
> II - fortalecer a prestação de serviços na atenção básica em saúde no País;
>
> III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação;
>
> IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;
>
> V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desenvolvidas pelos médicos;
>
> VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;
>
> VII - aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de saúde do País e na organização e funcionamento do SUS; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas no SUS.
>
> 2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define a saúde como direito da sociedade e responsabilidade do Estado, dando as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, o qual tem como princípios e diretrizes a universalidade, a equidade, a integralidade da atenção, a regionalização, a descentralização, a hierarquização e a participação social.
>
> 3. Por seu turno, o inciso III do artigo 200 da Constituição Federal de 1988 confere ao SUS a ordenação da formação de recursos humanos em saúde, cujo mercado de trabalho atualmente compõe-se de mais de 3 milhões de trabalhadores que necessitam de constante qualificação e reivindica aperfeiçoamento dos novos profissionais.
>
> 4. Por sua vez, o artigo 209 da Constituição Federal estabelece a livre oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que atendidas às condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. A oferta de educação superior de qualidade é fundamental para o processo de desenvolvimento nacional e melhoria da qualidade de vida da população."

No tocante ao pressuposto da urgência, a matéria deve ser examinada levando-se em consideração o já esposado entendimento da Corte, que exige comprovação acerca da inexistência da urgência. Ou seja, *"Trata-se de informações de alta indagação, que não podem ser convincentemente contraditadas por pronunciamentos especulativos, sem embasamento científico seguro. Nessas matérias de relevância e urgência se deve partir – e essa parece ser a jurisprudência do Supremo – da legitimidade das alegações, dessa fundamentação do poder normativo constituído."* (trecho do voto do Min. Teori Zavascki no supracitado RE 592.377).

Da leitura da Exposição de Motivos da MP, percebe-se que o Chefe do Poder Executivo, através do Ministro da Saúde, não se descurou de justificar a urgência da edição da medida, nos seguintes termos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

"(...)

5. O Plano Nacional de Saúde - 2012/2015 do Ministério da Saúde aponta como estratégia fundamental para o enfrentamento dos principais problemas de acesso da população às ações e serviços de saúde com qualidade a organização do sistema de saúde baseado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) que consistem em estruturas integradas de provisão de ações e serviços de saúde assegurados pelo SUS e tem como princípio a construção de uma intervenção unificada do Ministério da Saúde em articulação com estados, Distrito Federal e municípios.

6. Essas redes demandam ampliação da oferta de serviços públicos de saúde, sendo que com a expansão prevista até 2014 através exclusivamente dos investimentos do Ministério da Saúde, serão criados mais 35.073 postos de trabalho médico.

7. As Redes de Atenção à Saúde devem ser ordenadas pela Atenção Básica à Saúde, que é a porta de entrada prioritária do SUS. Esta se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades. Essa modalidade de atenção orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

8. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia de Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo possível verificar que o Brasil avançou muito nas últimas décadas nesta área. Entretanto, o país convive com muitos vazios assistenciais, que correspondem a localidades que não conseguiram prover e fixar profissionais de saúde na atenção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

básica, em especial os médicos, não garantindo acesso aos serviços básicos de saúde por parte da população brasileira.

9. Compreende-se que a atenção básica bem estruturada possibilita a resolução de até 85% dos problemas de saúde, contribuindo assim para ordenar as Redes de Atenção à Saúde – RAS e organizar a demanda para outros serviços, tais como os de urgência e emergência.

10. Ressalte-se, ainda, que na 14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2011, foi aprovada como diretriz que todas as famílias e todas as pessoas devem ter assegurado o direito a uma equipe de saúde da família.

11. O Brasil possui 359.691 médicos ativos e apresenta uma proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 (mil) habitantes, conforme dados primários obtidos no Conselho Federal de Medicina (CFM) e na estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

12. A proporção de médico/1.000 habitantes constatada no Brasil é menor do que em outros países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante ou países que têm sistemas universais de saúde, a saber: Canadá 2,0; Reino Unido 2,7; Argentina 3,2; Uruguai 3,7; Portugal 3,9; Espanha 4,0 e Cuba 6,7 (*Estadísticas Sanitarias Mundiales* de 2011 e 2012 – Organização Mundial da Saúde – OMS).

13. Não existe parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médico por habitante reconhecido e validado internacionalmente. Para tanto, utiliza-se como referência a proporção de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, que é a encontrada no Reino Unido, país que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter universal orientado pela atenção básica. Nesse cenário, para que o Brasil alcance a mesma relação de médicos por habitante seriam necessários mais 168.424 médicos. Mantendo-se a taxa atual de crescimento do número de médicos no país, o atingimento dessa meta só será viável em 2035.

14. A distribuição dos médicos nas regiões do país demonstra uma grande desigualdade, com boa parte dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

estados com uma quantidade de médicos abaixo da média nacional. A tabela abaixo demonstra essa distribuição (IBGE/2012 e CFM/2012):

(...)

15. Mesmo os estados com mais médicos que a média nacional apresentam importantes diferenças regionais. Um exemplo disso é o Estado de São Paulo que, em apenas cinco de suas regiões, apresenta um número superior a 1,8 médicos a cada mil habitantes (Demografia Médica no Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, 2012).

16. Uma das explicações para esse quadro está relacionada ao número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina. Apesar de um número absoluto de escolas médicas maior do que alguns países (são 200 escolas médicas), ao analisar-se a proporção de vagas de ingresso para cada 10.000 (dez mil) habitantes, o país apresenta índice significativamente inferior.

17. Enquanto o Brasil tem o índice de 0,8 vaga a cada 10.000 habitantes, outros países têm índices maiores, a saber: Austrália 1,4; Reino Unido 1,5; Portugal 1,6 e Argentina 3,1. Além disso, há estados em que esse índice é ainda menor, tais como Maranhão e Bahia (0,39).

18. A escassez de médicos em diversas regiões se manifesta em análises realizadas sobre o mercado de trabalho, como no estudo "Demografia do Trabalho Médico", do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Consoante esse estudo, entre os anos de 2003 e 2011, para 93.156 egressos dos cursos de medicina foram criados 146.857 empregos formais. Cabe considerar que nestes dados não estão incluídos os médicos que optam por ingressar na residência médica, médicos cooperativados ou autônomos. Desse modo, é possível concluir que uma parcela significativa dos médicos recém-graduados já ingressa no mercado de trabalho com a possibilidade de exercer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

mais de um emprego formal.

19. A população brasileira percebe e manifesta o desconforto com essa escassez de médicos, que tem impacto no acesso ao SUS. Em estudo do Sistema de Indicadores de Percepção Social, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em 2011, 58,1% dos 2.773 entrevistados disseram que a falta de médicos é o principal problema do SUS. No mesmo estudo, a resposta mais frequente como sugestão de melhoria para o sistema de saúde foi de aumentar o número de médicos.

20. Desse modo, encontramos um quadro de extrema gravidade, no qual alguns estados apresentam um número insuficiente de médicos e de vagas de ingresso na graduação, com ausência de expectativa de reversão desse quadro a curto e médio prazos, caso não haja medidas indutoras implementadas pelo Estado. Nesse cenário, a expansão de 2.415 vagas de cursos de medicina, anunciada pelo MEC em 2012, só contribuiria para atingir o número de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes no ano de 2035.

21. O Ministério da Educação autorizou em 2012 a oferta de cerca de 800 vagas privadas em cursos de medicina. Em que pese o aumento de vagas, o atual momento exige a adoção de iniciativas estatais para criar e ampliar vagas em cursos de medicina nos vazios de formação e de assistência, a partir do papel indutor do Estado na regulação da educação superior. Com isso, incentiva-se a criação de instituições de educação superior voltadas à área da saúde e à oferta de cursos de medicina nessas regiões. A autorização para oferta de cursos de medicina obedecerá a uma regulação educacional específica, com a publicação de chamamentos públicos às instituições de educação superior interessadas em se habilitar para atuação nas regiões que apresentem vulnerabilidade social, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação.

22. Além disso, entende-se que é fundamental agregar novas ações para garantir a ampliação da formação de médicos para a atenção básica no país, possibilitando à população

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

brasileira o acesso ao sistema de saúde de qualidade.

23. Uma das iniciativas é a ampliação de 12.000 novas vagas de residência médica acompanhadas da oferta de bolsas, a serem implementadas até 2017, uma vez que se entende a importância dessa modalidade para a fixação de profissionais. Estudo recente denominado Migramed, do Observatório de Recursos Humanos de São Paulo/ObservaRH, de 2012, demonstra que 86% dos médicos permanecem no local em que cursaram a graduação e a residência médica.

24. Uma das medidas proposta é a reformulação da grade curricular dos cursos de medicina, com acréscimo substancial de horas na formação específica na Atenção Básica. A presente Medida Provisória prevê que, para os ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1º de janeiro de 2015, a formação do médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares entre si, correspondendo o primeiro ciclo à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da carga horária não inferior a 7.200 horas, e o segundo ciclo ao treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos.

25. O segundo ciclo de formação será considerado componente curricular obrigatório do curso de graduação em medicina, inscrito no histórico escolar do estudante, e constituirá requisito para a obtenção do diploma de médico. Nesse período, o estudante fará jus ao recebimento de uma bolsa, com valor a ser definido pelo Ministério da Saúde. Poderá ainda ser aproveitado como uma etapa dos programas de residência médica ou de outro curso de pós-graduação.

26. Essa nova etapa representa uma importante estratégia para a formação médica, reforçando o conteúdo das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Medicina e apontando para a formação generalista de um profissional com senso de responsabilidade social e compromisso de cidadania.

27. Com vistas a enfrentar o problema da escassez de médicos no país, sobretudo em regiões prioritárias para o SUS,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

o Ministério da Saúde estabeleceu critérios para os municípios que apresentem condições de receber médicos para preenchimento de vagas em equipes de atenção básica, nos termos da Política Nacional de Atenção Básica, devendo o município enquadrar-se em um dos seguintes grupos: a) G100 (municípios com população superior a 80.000 pessoas, com baixa receita per capita e alta vulnerabilidade econômica); b) municípios com 20% ou mais de sua população vivendo em extrema pobreza; c) áreas de maior vulnerabilidade de capitais e regiões metropolitanas; e d) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

28. Além disso, os Ministérios da Saúde e da Educação desenvolvem políticas para responder a necessidade de provimento e fixação de médicos nas diversas regiões do país. Nos anos de 2012 e 2013, foram realizadas chamadas nacionais para médicos, através do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica/PROVAB, ofertando a possibilidade de curso de especialização na modalidade integração ensino-serviço em regiões de extrema pobreza e periferias, com incentivo aos participantes mediante acréscimo na pontuação no processo seletivo da residência médica.

29. Na primeira edição do Programa, apesar de uma demanda significativa dos municípios por esses profissionais, somente 381 médicos foram vinculados. Na segunda edição do programa, aderiram 2.838 municípios que solicitaram 13.862 médicos para atuar na atenção básica, sendo que apenas 3.577 médicos foram vinculados ao Programa para atuação em 1.260 municípios.

30. Ainda assim, mesmo com aumento importante na participação de médicos, permanece um número significativo de vagas ociosas, correspondendo a 74,2% da demanda inicial (Sistema de Gerenciamento de Programas da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde).

31. Tendo em vista a situação descrita acima, a instituição do Projeto Mais Médicos para o Brasil visa possibilitar a seleção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

de médicos interessados em participar de ações de aperfeiçoamento em atenção básica, em regiões prioritárias para o SUS.

32. Para tanto, serão oferecidos cursos de especialização, concessão de bolsas-formação, bem como será garantida contínua supervisão e acesso a recursos de suporte clínico, a exemplo do Telessaúde.

33. Para execução do Projeto Mais Médicos para o Brasil, além da atuação dos Ministérios da Saúde e da Educação, poderão ser celebrados termos de adesão e compromisso com Estados, Distrito Federal e Municípios, além de instrumentos de cooperação com outros países, organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, entidades públicas e privadas.

34. Nesse sentido, o Projeto Mais Médicos para o Brasil selecionará médicos para participarem do Projeto, garantindo-se a prioridade para a escolha de médicos formados em instituições de educação superior nacionais ou com diploma revalidado. Na hipótese de permanecerem vagas não preenchidas, estas serão ofertadas primeiramente a médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior e, posteriormente, a médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior, mediante chamamento público internacional ou celebração de instrumentos de cooperação com organismos internacionais.

35. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

informações, o monitoramento e a pesquisa no tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arco-Sur.

36. Baseado nas premissas preconizadas pela OMS, não poderão ser selecionados médicos oriundos de países que apresentem relação estatística médico/habitante menor que a do Brasil.

37. Ressalte-se que tais medidas não são dotadas de ineditismo, pois diversos países já as adotaram, a exemplo de Reino Unido, Canadá e Austrália.

38. Mesmo países com indicadores de relação médico/habitante superiores a do Brasil recorreram a programas de recrutamento de médicos estrangeiros para garantir o acesso ao sistema de saúde, geralmente com enfoque em áreas remotas. Dados apresentados pela *Organisation for Economic Co-operation and Development* – OECD, em 2009, e pelo *General Medical Council* do Reino Unido, em 2011, demonstram as seguintes proporções de médicos estrangeiros nos respectivos países: 37% no Reino Unido; 25,9% nos Estados Unidos; 22,8% na Austrália e 17,9% no Canadá.

39. No Brasil o percentual de médicos estrangeiros é de 1,79%, conforme dados primários do Conselho Federal de Medicina (2013).

40. Além disso, o médico formado em instituição de educação superior estrangeira será submetido a processo de acolhimento e avaliação, a ser desenvolvido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, a fim de garantir a adaptação aos princípios e diretrizes do SUS, a adequação à realidade epidemiológica brasileira e a capacidade de comunicação em língua portuguesa.

41. Também está sendo proposta a criação, mediante transformação, sem aumento de despesa, de Funções Comissionadas Técnicas – FCT em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS. Os 10 (dez) cargos em comissão (dois DAS-5 e oito DAS-4) que se propõe criar serão alocados em unidades administrativas de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

> órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para que tenham condições de constituir estrutura que se incumbirá de novas competências e responsabilidades, especialmente as decorrentes do Programa Mais Médicos.
>
> 42. A opção pela transformação – em vez da simples criação dos cargos necessários – se dá com a finalidade de neutralizar potencial impacto nas despesas de pessoal, alternativa que, de resto, já foi adotada em outras oportunidades. Dessa forma, a medida proposta não apresenta impacto orçamentário, já que a remuneração total das cento e dezessete Funções Comissionadas Técnicas que deixarão de existir equivale à remuneração total dos dez novos cargos em comissão obtidos com a transformação.
>
> 43. Nesse sentido, não obstante a descrição das ações já adotadas e planejadas para mitigar a escassez de médicos no país, as medidas proporcionadas pela presente Medida Provisória contribuirão para a melhoria do cenário da Saúde, notadamente na área da Atenção Básica.
>
> 44. O impacto gerado quando da adoção das estratégias traçadas pelo Programa reflete, de forma direta, a abrangência e relevância de tal medida, uma vez que se dará um salto no ingresso de médicos diretamente nas áreas mais necessitadas de profissionais, como já amplamente demonstrado pelos dados lançados nesta Exposição de Motivos.
>
> 45. A reordenação dos recursos humanos na área da Saúde e a reformulação da grade curricular dos cursos de medicina – com acréscimo substancial de horas na formação específica na Atenção Básica – visam garantir o acesso a um sistema de saúde universal e de qualidade a toda população brasileira.
>
> 46. Por seu turno, no que se refere à urgência da Medida Provisória, é possível verificar que a eficácia das medidas propostas somente será alcançada pela agilidade de sua implementação, de forma coordenada e conjunta.
>
> (...)"

O parâmetro para se avaliar essas alegações é, como indicou o Min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

Teori Zavascki em manifestação já referida neste voto, "*se deve partir (...) da legitimidade das alegações, dessa fundamentação do poder normativo constituído.*"

Nesse sentido, ainda que a parte ora requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da Medida Provisória impugnada nesta ação direta.

Quanto às alegações de inconstitucionalidade material, não há violação ao princípio constitucional do concurso público, nem imposição de servidão civil aos estudantes do curso de medicina, nem limitação territorial do exercício da profissão, nem, tampouco, temática ligada à racionalidade, cidadania e orçamento.

Em relação aos argumentos de ofensa ao art. 37, II, da CRFB, assiste razão jurídica ao Procurador-Geral da República, quando aduz que "a natureza jurídica das contratações é a definida no inciso IX do art. 37 da Constituição, que admite seleção simplificada para as contratações de pessoal por tempo determinado", o que demonstra amparo constitucional da exceção à regra do concurso.

No que tange à inconstitucionalidade relativa ao exercício ilegal da profissão (arts. 13, 15 e 16 da Lei e 7º, 9º e 10 da MP), o que, no entender da requerente, decorreria do fato de permitir o exercício da medicina a quem não revalidou seu diploma, é preciso observar que o dispositivo constitucional invocado, constante do art. 5º, XIII, da CRFB, garante a liberdade do trabalho, "atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Como se depreende da leitura do texto constitucional, as limitações ao livre exercício profissional dependem de lei que deverá prever qualificações necessárias para o seu exercício. Noutras palavras, devem haver qualificações para o exercício profissional e tais qualificações devem estar previstas em lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

A previsão legal, ainda que por meio de medida provisória, atende ao comando constitucional. Além disso, não se pode dizer que a lei não preveja qualificações, embora ela as tenha fixado em condições diversas da que vigoravam anteriormente. Pode a lei, desde que observe os parâmetros constitucionais, revisar as qualificações anteriormente previstas.

É porque a lei preenche essas funções que também devem ser afastados os argumentos relativos à autonomia universitária ao fundamento de que não haveria como ser comprovado o conhecimento obtido pelos profissionais oriundos de outros países. A referência feita à formação no estrangeiro é tida como qualificação suficiente pela lei, opção política justificável à luz do art. 5º, XIII, da CRFB.

Os Conselhos Profissionais, como autarquias responsáveis pela fiscalização das qualificações estabelecidas em lei, devem limitar-se, nos termos do art. 37, XIX, da CRFB, ao controle de legalidade do exercício profissional, não se podendo falar em ofensa a sua autonomia, caso tenha a lei optado por qualificações distintas daquelas que anteriormente havia fixado.

É preciso consignar, ademais, que as informações apresentadas pela Advocacia-Geral da União atestam a celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no qual se prevê, expressamente, que os profissionais migrantes "gozem de oportunidade e de incentivos para melhorar a sua formação profissional, qualificações e estatuto, numa base de igualdade de tratamento com os profissionais de saúde formados a nível nacional".

Cumpre assentar que esse tipo de contratação está, em tese, contida na dispensa de licitação, a qual, por sua vez, prevista no art. 25 da Lei impugnada. A dispensa de licitação está contida na exceção prevista no art. 37, XIX, da CRFB, razão pela qual não se pode falar em ofensa a esse dispositivo. Isso não significa, porém, que tais atos não estejam sujeitos ao controle externo a cargo do Poder Legislativo, nem ao controle judicial, caso contenham vícios de legalidade.

Relativamente à alegação de ofensa ao princípio da proibição de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

servidão, aduz-se que a previsão constante do art. 16 da Lei, que dispõe que "as atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza", não prevê nenhum regramento salarial ou de limitação de jornada. Haveria, assim, no entender da requerente, proteção deficiente do direito ao trabalho.

Especificamente no que tange aos médicos intercambistas, conceito previsto no art. 13, § 2º, II, da Lei ("médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior"), a quem é proibido o exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos (art. 16), é preciso observar que, mesmo nessa condição, terão os médicos direito a perceber bolsas, nos termos do art. 19 da lei impugnada.

Não bastassem as remissões específicas ao caráter formativo do Programa, tal como se depreende, *v.g.*, dos arts. 13 a 15 da Lei, a referência a remuneração por meio de bolsa indica a opção feita pelo legislador pela natureza educacional do projeto, a afastar a alegação de que a ausência de vínculo empregatício poderia equivaler à servidão.

Em relação aos argumentos que sustentam violação do princípio da isonomia , é preciso registrar que o princípio da igualdade formal, como invocado pela requerente, proíbe que se instituam "discriminações ou tratamentos diferenciados baseados em fundamento que não seja razoável ou que não vise a um fim legítimo" (OSÓRIO, Aline; BARROS, Luís Roberto. "Sabe com quem está falando?" Notas sobre o princípio da igualdade no Brasil contemporâneo. In: Direto & Práxis Revista, Rio de Janeiro, Vol. 07, n. 13, p. 209).

Não é disso, porém, que trata a medida provisória atacada. Com efeito, a Lei estabelece, logo em seu art. 1º, I, que um de seus objetivos é "diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área a saúde". O fim é, sem dúvidas, legítimo, como se depreende da leitura do art. 196 da CRFB.

A contratação de profissionais estrangeiros é, sob essa perspectiva, adequada, porquanto não haveria tempo hábil para que, por meio apenas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

da formação de novos quadros, outros profissionais pudessem fazer os atendimentos destinados aos profissionais de outros países. A lei é, ainda, cautelosa em privilegiar os médicos que se formaram no Brasil, possivelmente para, nos termos do art. 1º, II e III, aprimorar a formação médica", além de "fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País".

Ademais, as informações apresentadas pelo autor da política pública, que detém capacidade institucional para formulá-las, dão conta de que é, realmente, baixo o número proporcional de médicos no Brasil, a justificar a edição da medida provisória.

Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 37, I, da CRFB, o acesso a cargos e funções públicas é também acessível a estrangeiros, observados os requisitos legais.

Assim, não é irrazoável, ao contrário, é proporcionalmente adequada a opção política formulada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação direta.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166379.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também eu, ouvindo com toda atenção o voto do Ministro Marco Aurélio, estou acompanhando a posição do Ministro Alexandre de Moraes nessa questão da invalidação do registro sindical pronunciada por esta Corte no ARE nº 919.995, da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, Ministra Cármen Lúcia, que, a meu ver, impede que se atribua à requerente a condição de entidade sindical de grau superior.

Por essa razão, eu também entendo que a hipótese é de ilegitimidade ativa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14187071.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente, embora eu comungue com o pensamento do Ministro Marco Aurélio no que tange a uma interpretação menos restrita do art. 103, IX, da Constituição Federal, quando atribui legitimidade ativa *ad causam* a entidades sindicais de âmbito nacional - esses são os termos da Constituição –, eu, no caso concreto, diante justamente desses dados fáticos que foram trazidos pelo Ministro Alexandre, no que diz com a compreensão desta Corte especificamente quanto a essa condição pela autora da ADI nº 5.037, acompanho Sua Excelência, o Ministro Alexandre, extinguindo a ação, sem resolução do mérito, pedindo toda vênia ao Ministro Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14220522.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS - CNTU
ADV.(A/S)	: JONAS DA COSTA MATOS
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL DRª MAÍRA FACHINI - AMN-MF
ADV.(A/S)	: DOUGLAS BORGES DE VASCONCELOS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Presidente, faço apenas uma observação.

Sabemos que o registro, no Ministério do Trabalho, para a valia jurídica de entidade sindical foi suplantado pela Carta de 1988, que se diz democrática. E não me consta que essa Confederação tenha tido o registro, no Cartório de Pessoas Jurídicas, afastado, isso quanto à existência. Por isso é que entendo não haver o prejuízo, em si, sob o ângulo da legitimidade, da ação direta de inconstitucionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246461.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, eu também comungo da ideologia do Ministro Marco Aurélio quanto à seriedade da pretensão em legitimar-se determinadas entidades. Mas, se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancelou esse pré-requisito que conduz à legitimidade, eu fico realmente sem outra alternativa a não ser acompanhar a divergência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Em última análise, todos devemos estar sendo coerentes, porque certamente fiquei vencido nesses precedentes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246462.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhora Presidente, também eu peço vênia ao Ministro **Marco Aurélio** para acompanhar a divergência.

E anoto, então, que não conheço da ADI nº 5.037, na linha da divergência aberta pelo Ministro **Alexandre de Moraes**.

Mas, Senhora Presidente, também gostaria, já que estamos falando de legitimidade ativa, de destacar que, na ADI nº 5.035, são dois autores, dois requerentes: a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. E, com bastante precisão, trouxe o Ministro Relator seu olhar sobre a legitimidade do Conselho Federal de Medicina.

E eu já anoto, desde já, se me permitem os Colegas, que também aqui não conheço da ação, da legitimidade ativa do Conselho.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Ministro, quanto ao Conselho, prolatei decisão, não impugnada, assentando a ilegitimidade.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Exatamente isso!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Admiti o Conselho como terceiro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ah, o Conselho está como terceiro!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O denominado amigo – não sei se amigo ou inimigo – do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Está bem, então, o Conselho não é mais parte.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Por isso que eu pus agora apenas a 5.037, no qual se punha a questão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587253.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também eu, Presidente, acompanho a divergência trazida agora pelo Ministro Alexandre de Moraes diante, inclusive, da decisão - acho que uma delas é de Vossa Excelência -, quanto à própria nulidade do registro.

Mas, Presidente, eu gostaria, considerando esse incidente, de fazer o registro e revelar uma preocupação. Acho que, como nós estamos nos avizinhando do final do ano, seria interessante que todos nós nos munníssemos de energia nova para nos reinventarmos. O que eu percebo é que nós estamos caminhando rapidamente para uma situação de completo impasse na nossa atividade, por razões as mais diversas. São sustentações que são feitas, depois nós não conseguimos julgar o próprio mérito; ou esses impasses em torno de temas que ficaram aí por anos a fio.

De modo que me parece que, com o perdão da sinceridade, nós devemos talvez criticamente analisar o nosso afazer na Corte, porque estamos caminhando para um atoleiro ímpar. Quer dizer, de fato o Plenário está - isso já vem sendo dito - bastante inviabilizado. Veja que nós passamos a tarde toda discutindo esse tema para, no final, dizer: "Bom, não se conhece da ação".

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - São duas ações.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, sim.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E aqui a preliminar, Ministro ...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas a mais ampla é esta.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A parte dispositiva, inclusive, contempla...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, eu só estou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587254.

usando isso como *leitmotiv*, porque, na verdade, é uma consideração geral, tendo em vista tudo aquilo que se vem repetindo aí ao longo deste ano, mas também já, talvez, do ano passado, as dificuldades que nós temos e que de fato nos desafiam. Nós temos que, realmente, de alguma forma, em alguma medida, nos reinventar.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim, inclusive repensando, porque o Plenário, para julgar mais, talvez a gente tenha que adotar julgamentos mais rápidos. As Turmas atuam uma vez por semana e com celeridade maior. Talvez seja o caso mesmo de a gente pensar, inclusive, a forma de atuação aqui do Plenário.

Acho que Vossa Excelência tem razão, mas isso depende de todos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587254.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: **Peço vênia**, Senhora Presidente, ao eminente Relator, **para acompanhar a divergência** iniciada pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES. *Em consequência*, **e em razão da ilegitimidade ativa** "*ad causam*" da entidade autora (**ADI** 4.380-MC/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO), **não conheço** da presente ação direta, **declarando extinto** este processo objetivo de controle normativo abstrato.

É o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5332-39C9-E819-8779 e senha 715D-11EE-87C3-BBB5

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Também peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência iniciada pelo Ministro Alexandre de Moraes no sentido de não reconhecer legitimidade ativa à entidade, e, neste caso também, concluir no sentido da extinção da ação sem resolução de mérito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14587255.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.037
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS - CNTU
ADV.(A/S) : JONAS DA COSTA MATOS (0060605/SP)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL DRª MAÍRA FACHINI - AMN-MF
ADV.(A/S) : DOUGLAS BORGES DE VASCONCELOS (16152/MS)

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa *ad causam* da requerente e determinou a extinção do processo. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski. Falou, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.11.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14202535